

国家医疗保障按病种分值(DIP)付费

3.0 版技术规范

(征求意见稿)

编写说明

深化医保支付方式改革，建立管用高效的医保支付机制，是党中央、国务院对深化医保制度改革的任务要求，是医保制度不断发展完善、持续提高基金使用效能的必要举措，也是医改领域协同推进需求侧管理和供给侧改革的关键环节，事关医保、医疗和医药事业高质量发展。

随着人口老龄化、健康意识提升、医疗服务需求增加，新药、新材料、新技术、新设备加速发展和应用，以及医药服务供给侧规模变化等导致医药费用规模不断扩大，基本医保基金支出压力持续加大。从医保制度价值来说，不仅要维持基金收支平衡，还要通过支付杠杆，调控医疗资源配置和医疗机构行为，让参保人获得有品质的医疗服务；不仅要为参保人分担医药费用，还要努力减轻患者就医经济负担，提升人民群众在健康保障领域的获得感、幸福感、安全感。支付方式改革正是发挥这一价值的重要手段。

2020年10月，国家医保局启动区域点数法总额预算和按病种分值付费（DIP）国家试点工作。2021年底，71个国家试点城市全部实现实际付费。在此基础上，国家医保局发布《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》（以下简称“三年行动计划”），为实现改革进度、质量、效果目标提出了时间表、路线图，并确定了示范城市，推动改革从局部试点转向全面覆盖、从快速启动转向夯实基础、从具体方法转向机制形成。在各方努力下，“三年行动计划”圆满收官。国家医保局于2025年8月颁布《医疗保障按病

种付费管理暂行办法》（医保发〔2025〕18号），进一步明确支付方式改革提质增效的关键技术和配套机制。并委托首都医科大学国家医疗保障研究院（以下简称医保研究院）组织 DIP 技术指导组专家，在开展 DIP3.0 病种分组动态调整的同时，启动 DIP3.0 版技术规范修订工作。

DIP3.0 版以 2.0 版为基础，按照党的二十届四中全会关于深化医保支付改革的新要求，围绕改革目标、数据基础、病种分组、按病种付费总额、核心要素、支付标准、结算清算、监测分析等 DIP 支付全流程各环节，突出 DIP3.0 版分组规则调整优化，强化预付金、特例单议、谈判协商、数据工作组等配套机制实施，贯穿融合了各方对病种付费在理论研究、管理实践中的新认识与新经验，对 DIP 分组技术规范做了系统修订。

DIP 作为利用大数据优势建立的医保支付方式，以尊重临床、服务临床、引导临床为设计理念，通过持续完善核心要素管理、优化各项配套机制，不断探寻具有中国特色、体现时代特征的现代化医保支付体系。

目 录

第一章 概述	1
第一节 DIP 基本概念	1
第二节 总体要求	4
第三节 组织实施	7
第二章 基础数据与信息系统建设	14
第一节 数据来源及使用	14
第二节 医保结算清单	15
第三节 支付方式管理子系统	24
第三章 病种分组	28
第一节 成组原理	28
第二节 成组规程	32
第三节 国家病种库和地方病种库	41
第四节 基层病种	48
第五节 病种动态调整	49
第四章 按病种付费总额	52
第一节 编制原则	52
第二节 总额确定	53
第三节 分配与执行	54
第五章 核心要素	57
第一节 分值及计算	57
第二节 调节系数	60
第三节 当年病例分值	66

第四节 年初点值计算及应用	67
第五节 结算点值计算及应用	70
第六章 支付标准	72
第一节 计算方法	72
第二节 特例单议机制	74
第三节 谈判协商机制	75
第七章 结算清算	77
第一节 日常审核	77
第二节 基金结算	78
第三节 基金清算	80
第八章 运行监测	86
第一节 工作实施	86
第二节 监测指标	88
第三节 数据发布	93
附录:	99
名词解释	99
医疗保障按病种付费管理暂行办法	104
按病种付费医疗保障经办管理规程（2025 版）	113
医保基金清算提质增效三年行动计划	123

第一章 概述

第一节 DIP 基本概念

一、定义

按病种分值付费（Diagnosis-Intervention Packet，DIP）是利用大数据优势所建立的医保支付方式。它是基于“疾病诊断+治疗方式”的共性特征，对医保结算清单数据进行客观聚类，形成 DIP 病种，对各病种测定分值，再依据医保基金预算计算点值，用病种分值和点值形成支付标准，配套支付管理一系列关键机制，对 DIP 病种进行结算清算的医保支付方式。

基此，形成以大数据为基础，以按病种付费总额为前提，病种组合、分值计算、点值计算、结算清算、运行监测和配套机制为关键环节的全流程技术规范，如图 1-1 所示。

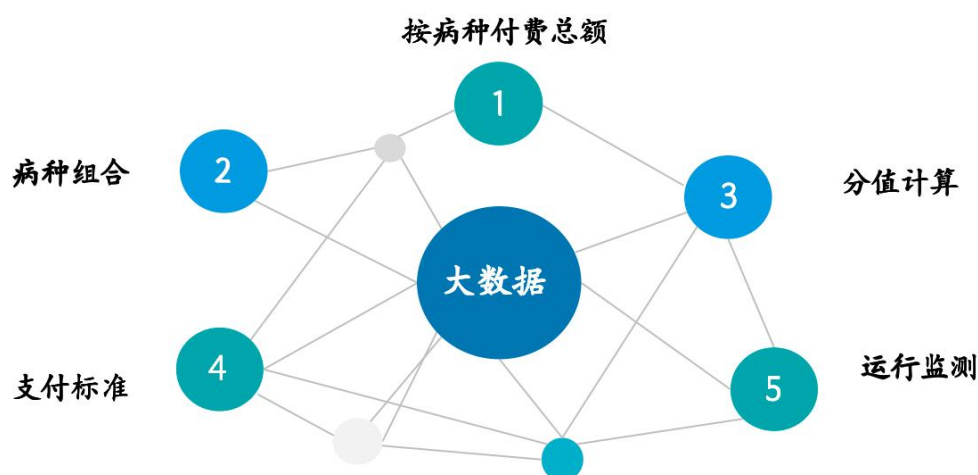


图 1-1 DIP 技术框架示意图

DIP 主要适用于定点医疗机构住院医疗费用（包括日间手术）

结算。对于医疗康复、安宁疗护和精神类疾病等需要长期住院治疗的，宜采用按床日付费，各地也可探索基于 DIP 的床日分值结算方式。

支付方式改革的目标是实现医、患、保多方共赢，更好发挥医保价值购买作用，实现医保基金可持续、医疗服务提质增效、群众就医负担合理可控。通过科学、合理、精准的支付，补偿医疗机构的资源消耗，对医疗卫生资源合理配置、医院精细化管理、诊疗服务规范，发挥有效的杠杆导向作用。DIP 有利于增进医保、医疗管理的透明度与公平性，使政府、医保、医院各方以改革目标为导向，在统一标准框架下建立协商沟通机制，实现医保、医疗、医药协同治理发展。

1.提高基金管理效能

DIP 突出按病种付费总额管理和支付标准，以病种为计价单元和付费基础，可使支付标准更具科学性、精准化，有利于实现价值购买，同时，也促进医保管理经办规范化、精细化和科学化。

2.促进供给侧结构改革

DIP 以尊重医疗服务复杂性及内在规律为前提，将在三个层次对供给侧进行调控。一是通过按病种付费总额，调控区域医疗总费用，促使区域卫生资源配置规模适宜和结构布局优化；二是通过 DIP 付费单元和支付标准的确定，以及“结余留用、合理超支分担”的激励约束机制，引导医疗机构转变管理导向和运营机制；三是引导医务人员从临床需要出发，以适宜的方法、合理的成本提供医疗

服务，有利于医学科技进步，提高医疗服务质量和诊疗安全。

3.维护参保人权益

DIP 立足价值购买，从成组逻辑到分值计量等关键技术及内在机理，促进医疗机构提供更规范的诊疗服务，患者医疗质量安全得到更好保证，费用更加合理；提升患者就医体验感，正向引导医疗机构对危重、疑难病例的合理收治，减少推诿现象。同时，合理控制医疗服务成本，避免医保基金低效和浪费，减轻患者个人负担，保障参保人利益，提升人民群众在医疗卫生服务保障领域的获得感、幸福感、安全感。

二、主要特征

（一）以大数据为依据

大数据的汇聚与应用，贯穿于 **DIP** 成组、按病种付费总额、分值点值计算、结算清算以及运行监测各环节、全过程，主导支付体系的完整构建，并连接医疗服务和医保管理乃至经济社会发展全链条。强调挖掘应用历史数据与现实数据、本地纵向比较数据与横向比较数据；建立标准数据体系，如按病种临床路径下的正常资源消耗等；以及典型数据、科研积累数据等。基于医疗医保数据，拓展延伸到经济社会发展、人群健康等主要指标，分析区域内病种结构及其变化，促进精细化管理和科学决策。

（二）以病种总额为基础

实行按病种付费总额管理，即按分配给 **DIP** 结算的基金额度，计算结算点值和病种支付标准，发挥调控和激励约束作用。

（三）以病种为单位制定付费标准

病种是落实临床路径、评价治疗过程和诊疗效果的对应单元。DIP 病种组合致力于寻找与临床更为契合的付费单元，综合考虑更大样本数据和标准数据（即临床路径下的资源消耗），对支付标准进行纵向和横向比较分析和校正，以客观、精准反映疾病严重程度、治疗复杂状态、资源消耗水平，促进临床行为规范。

（四）形成激励约束机制

医保对定点医疗机构实行 DIP 付费，通过“结余留用、合理超支分担”机制，体现医保基金对医疗机构管理和服务行为的激励约束，引导医疗机构主动规范服务行为、合理控制成本，从而获得病种结余资金，实现医保基金使用效率提升与医疗机构良性发展的统一。

第二节 总体要求

一、政策要求

2017 年 6 月，《关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》（国办发〔2017〕55 号）要求进一步加强医保基金预算管理，全面推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式，将支付方式改革推向新阶段。

2020 年 2 月，《中共中央 国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》（以下简称《意见》）明确了医保制度改革的指导思想、基本原则和总体目标，提出“1+4+2”的总体改革框架。《意见》提出，要建立管用高效的医保支付机制，完善医保基金总额预算办法，大

力推进大数据应用，推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式改革。探索对紧密型医疗联合体实行总额付费，加强监督考核，结余留用、合理超支分担。坚持系统集成、协同高效，增强医保、医疗、医药联动改革的整体性、系统性、协同性，保障群众获得高质量、有效率、能负担的医药服务。

2021 年 9 月，国务院办公厅印发《“十四五”全民医疗保障规划》（以下简称《规划》），提出持续深化医保支付方式改革。在全国范围内普遍实施按病种付费为主的多元复合式医保支付方式，推进区域医保基金总额预算点数法改革，引导医疗机构合理诊疗，提高医保资金使用效能。完善紧密型医疗联合体医保支付政策。

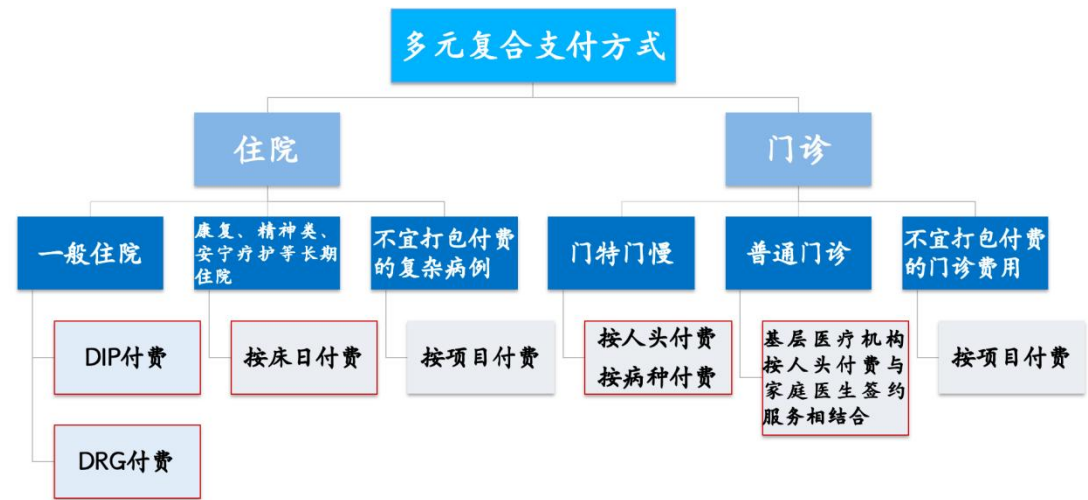


图 1-2 多元复合式医保支付方式

2021 年 11 月，国家医疗保障局印发《关于 DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划的通知》（医保发〔2021〕48 号），对 DRG/DIP 支付方式改革作出阶段性系统部署。到 2024 年底，三年行动计划既定任务已完成，改革阶段性目标总体实现，为按病种付费改革持续

深化奠定了制度基础。

2025 年 1 月，国家医疗保障局在总结改革经验与成效的基础上，印发了《按病种付费医疗保障经办管理规程（2025 版）》，对协议管理、数据采集、预算管理、核心要素管理、结算清算、数据公开等经办要求作出具体规范。2025 年 8 月，国家医疗保障局印发《医疗保障按病种付费管理暂行办法》，进一步明确国家、省级和统筹地区医保部门在按病种付费管理中的职责分工，系统规范总额预算管理、病种分组及动态调整、核心要素管理、特例单议、结算清算、协议管理、监测评估、数据治理和信息化支撑等重点内容，并对长期住院、门诊、中医优势病种及异地就医等领域支付方式改革作出部署，为持续推进以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式改革提供了制度依据。

二、总体原则

（一）数据驱动、标准先行

以聚集全人群、全样本的医保医疗数据，落地应用国家医保信息业务编码标准为基础，国家发布 DIP 技术规范，各省据此制定省域内实施方案，指导督促各地市建立本地区的实施方案及路径。充分发挥国家和地方数据联动优势，推动医保支付制度改革平稳、有序、见效。

（二）基于客观、科学测算

基于历史数据形成病种库，切合临床实际，直观、客观反映医疗服务行为。采用大数据方法精确拟合成本，结合各地经济发展水

平、医保筹资能力以及医疗机构的功能定位，科学测算分值、点值及调节系数，确保医保支付科学合理，促进医保医疗事业高质量、可持续发展。

（三）公开透明、全程监管

建立公开透明、多方参与的核心要素调整机制，推动统一数据标准体系下医保支付方式与智能监管的一体化，推进从事后审核向事中拦截和事前提醒延伸，形成基于大数据病种分值下的异常费用发现机制与过程控制机制，创建“公平、公正、公开”的支付与监管生态。

（四）供需平衡、多方共赢

建立医疗保障科学管理机制，引导区域卫生资源的合理配置、提升资源利用效率；促进医疗机构精细化管理，以“结余留用，合理超支分担”激发医疗机构控制成本的内生动力，提供适宜的服务、控制医疗费用不合理增长，提高医保基金使用效率，维护参保人权益。

第三节 组织实施

一、国家医保局统筹部署

（一）统一技术规范，建立动态调整机制

国家医保局负责制定和调整国家版按病种付费分组方案，统一明确改革方案和技术标准。根据医保管理要求和医疗服务实际需要，依托全国统一的医保信息平台采集医保结算清单、医疗费用明细等相关数据，按照质控规则进行清洗、处理，形成分组基础数据库；

同时建立常态化意见收集反馈机制，分级分类做好医疗机构和一线医务人员意见建议的收集、反馈和汇总上报工作。在真实数据基础上，通过临床论证、数据验证并征求相关部门意见后，形成国家版分组方案。国家建立病种分组方案动态调整机制，原则上每两年调整一次，并在当年7月底前发布；国家版分组方案调整后，省级和统筹地区医保部门应结合实际及时做好本地分组衔接和调整。

（二）加强组织协调和工作指导

国家医保局统筹推进按病种付费管理，围绕总额预算、分组方案、核心要素、特例单议、结算清算、协议管理、监测评估、数据公开等重点环节，加强制度设计、工作调度、经验交流和督促指导，推动按病种付费管理与基金预算管理、经办管理、清算提质、数据治理和基金监管等配套机制协同衔接，促进改革规范有序实施。

二、地方推进落实

（一）省级医保部门组织落实

省级医保部门对推动本地区按病种付费改革负主体责任，按照国家统一部署落实省域内按病种付费管理职责，指导统筹地区做好政策落地、技术衔接、经办规范和运行管理等工作，逐步实现省域内病种付费政策、技术标准和服务管理统一。积极推进省级病种库建设。

（二）统筹地区医保部门具体实施

统筹地区医保部门负责具体工作落实，加强与相关部门、医疗机构的协调配合，细化实施办法和管理措施，有序推进改革落地。

DIP 改革地区应遵循国家医保支付方式改革的统一部署要求，结合本地实际，制定 DIP 支付方式改革实施方案，明确改革目标任务，系统规划改革路径和方法，创造改革配套条件。

地方 DIP 实施具体包括以下工作步骤：

1.组织协调

成立 DIP 支付方式改革领导小组，可由分管市领导任组长。医保部门主要负责同志抓落实。成立工作专班并按照职责分工全面落实改革任务和要求。同时，医保部门要加强与财政、卫健等部门沟通协调，并充分调动医疗机构的积极性，确保改革持续深化。

2.基线调查

设计基线调查表，开展基线调查，对本地经济社会情况、基金运行情况、医疗服务供给和利用情况等情况进行动态摸底和分析，为测算基金分配方案、预判改革风险、评估改革效果等奠定基础。

3.拟定基金分配方案

在年度医保基金支出总额的基础上，根据总额预算增长影响因素、基础增长率等，合理计算用于 DIP 支付的职工医保和居民医保基金额度。

4.形成本地病种库

按照国家病种库及病种聚类规则形成本地 DIP 病种。即通过采集开展住院服务的医疗机构历史数据，聚类形成核心病种、综合病种组合结果，与医疗机构开展沟通协商，科学确定本地病种及病种分值，形成本地病种库。

5.测算分值与调节系数

以全部病例平均住院费用或基准病种的次均医疗费用作为基准，计算各病种的分值。其中，根据实际需要，可对部分病种设置病种分值调节系数，具体包括医疗机构调节系数和辅助分型调节系数。

6.模拟测算

一是模拟计算 DIP 结算情况。使用往年（如上一年）历史数据按照拟定的新年度 DIP 支付方案进行模拟测算，包括总费用、按 DIP 结算费用、平均结付率、医疗机构承担费用及比例、与实际结算承担费用差值等指标，并可按不同医疗机构、不同级别医疗机构进行统计。二是对比分析结算差异。将 DIP 模拟测算结果与原支付结果进行比较，分析预判 DIP 结算方式的实施效果，作为评价和调整的参考。

7.实际付费

在完成数据采集、病种成组、配套政策制定、模拟测算等 DIP 实际付费前的准备工作后，择时进入实际付费阶段，按经办规程完成年度结算、清算等。

三、协议管理

（一）基本要求

医保经办机构应将按病种付费相关要求纳入医保服务协议管理，与定点医疗机构通过签订医疗保障服务协议，明确双方权利义务，按病种付费相关的协议内容原则上包括：按病种付费的定点医疗机构做好信息系统完善、医疗保障基金结算清单及相关数据上传等工

作；经办机构明确医保基金结算方式、拨付时限、支付标准、考核评价等管理要求。统筹地区根据按病种付费实际需要，完善协议管理内容，落实按病种付费经办管理流程，强化定点医疗机构履约责任。省内异地就医住院费用纳入按病种付费范围的，应纳入就医地协议管理。

（二）医保部门职责界定

1.政策传导

医保经办机构应及时向定点医疗机构通报 **DIP** 政策和管理规定情况，指导医疗机构开展与 **DIP** 相关的培训、接受咨询并反馈意见建议。

2.费用审核

医保经办机构通过智能审核等手段审核医疗费用，将结果及时反馈医疗机构并予以处理，不得影响参保人结算；对界定清楚的违规、违约行为，可按约定直接处理。对于特殊病例、费用偏差病例等，医保部门可定期组织专家开展评议。

3.基金拨付

参保人员住院发生的医疗费用，医疗机构按要求申报后，由医保经办机构按照协议约定进行结算拨付，并按规定进行年度清算。

（三）医疗机构组织实施

1.DIP 管理

医疗机构应按规定做好 **DIP** 管理工作，规范诊疗行为，保证医疗质量，为参保人员提供优质、便捷的医疗服务。

2.数据质量

医疗机构应按照 DIP 数据传输要求，在规定时间内上传《医疗保障基金结算清单》（以下简称“医保结算清单”）、病案首页等就医数据，医保结算清单、病案首页填写应当真实、规范、完整，准确反映住院期间诊疗信息。

3.考核评价

疾病和手术操作代码准确率、数据上传情况等 DIP 考核指标可纳入定点医疗机构绩效考核范围。

（四）争议处理

争议处理遵循公平公正、客观合理、多方参与、及时处理的原则。开展按病种付费争议处理，及时妥善解决工作开展、履行协议过程中产生的争议问题。

对在按病种付费中出现的各类纠纷，可采取专家评议或其他形式，按照医疗保障服务协议及相关法律法规处理。

四、DIP 技术指导组专业支撑

（一）形成常态化工作机制

国家医保局统筹推进 DIP 技术指导组建设工作，建立并动态更新 DIP 技术指导专家库。2026 年，国家医保局与卫健部门协同，动态调整了 DIP 技术指导组，形成七个工作组，由医保研究院负责 DIP 专家组日常管理和组织协调等工作。技术指导组的工作职责主要包括：**一是**承担国家医保局部署的 DIP 技术规范和国家病种库动态调整等研究工作，开展 DIP 改革咨询、培训、监测、效果评价等

专业技术工作。二是推进多部门协同，促进医保、卫健、医疗机构的信息沟通交流，聚集各领域专家学者的专业力量。三是形成分工协作、定期报告、评价考核等专家组管理工作机制。

（二）技术规范 and 病种库研究

开展 DIP 支付理论体系研究，以医保支付理论为基础，创新 DIP 支付理论，总结提炼实践经验，深化关键技术研究，制定并不断完善国家医保 DIP 技术规范，研究 DIP 国家病种库的版本迭代升级。同时，积极探索 DRG/DIP 融合路径，推进按病种付费方式在病种组合规则和结果及管理机制上的协同研究，为探索中国特色医保支付体系提供技术支撑。

（三）开展监测评估

开展 DIP 改革实施跟踪评估。编制 DIP 改革监测指标，监测改革推进情况，总结典型经验做法，为国家医保不断深化 DIP 付费改革提供决策参考。

（四）提供培训指导

DIP 技术指导组专家按照改革实际，主动开展对重点地区的技术指导。各地根据改革实施情况，邀请技术指导组专家开展培训或召开专题研讨会，探讨重点、难点问题、交流典型经验等。

第二章 基础数据与信息系统建设

按病种付费基础数据和信息系统建设，是制定分组方案、测算支付标准、开展结算清算、审核核查和运行监测的重要基础。各地应依托全国统一的医保信息平台，统一规范应用国家医保信息业务编码标准，做好数据采集、结算清单上传、数据治理和系统支撑等工作，为按病种付费管理提供可靠的数据和平台支撑。数据采集、传输和使用应当符合数据安全要求，强化数据安全审批、分级分类管理和重要数据保护，保障数据总体安全可控。

第一节 数据来源及使用

一、基线数据

基线数据是指通过基线调查收集的基础资料。一是用于制定测算方案，科学实施按病种付费总额。二是用于进行 DIP 实施前后的比较，比较医保基金、病种支付标准、病种费用及结构变化，以更好地分析原因，降低实施风险，并客观评价医保支付与监管工作成效。

基线数据具体包括经济社会情况（人均 GDP、城乡居民人均可支配收入、物价水平变动等）；基金运行情况（参保结构、基金累计结余、医保待遇水平、人均筹资水平等）；医疗服务供给和利用情况（医疗机构总量和结构、每千人口床位数、住院流向结构、住院异地就医情况、医疗服务总费用、住院率、医疗技术水平、医疗

质量等)；以及患者医疗需求、患者费用负担等。

二、前三年数据

前三年数据主要用于病种分组、权重(分值)和费率(点值)测算,以及相关核心要素的调整优化。数据应以住院医疗费用相关真实数据为基础,能够较为客观地反映本地历史住院服务和资源消耗情况。各地应结合实际,对前三年数据进行采集、核验、清洗和处理,提高数据质量,夯实按病种付费管理基础。

三、当年数据

当年数据是开展月度结算、年度清算、审核核查、运行监测和综合评价的重要基础。各地应依托医保信息平台,及时采集和汇总当年发生的结算清单、医疗费用明细等数据,确保数据真实、完整、准确、及时,为按病种付费实际运行提供支撑。当年数据是指改革地区的定点医疗机构在当年度医疗服务过程中产生的医疗交易数据。**一是**经数据质控后用于进行病例入组匹配、费用异常病例分值调校、确定病例总分值、测算点值等。**二是**经费用审核后,用于月度预付和年度清算。**三是**通过大数据统计分析,监管医疗机构不规范诊疗行为,监测分析付费运行质量及改革效果。具体包括医保结算清单和医保费用明细表,依照信息传输要求,以电子化的形式直接采集或传输,实时上传至国家医保信息系统。

第二节 医保结算清单

医保结算清单是定点医疗机构在开展住院、门(急)诊等医疗

服务后，向医保部门申请费用结算时所需提交的数据清单，是医疗机构与医保部门间的统一结算凭证。医保结算清单包括“基本信息”“门诊慢特病诊疗信息”“住院诊疗信息”与“医疗收费信息”四个模块，共计 193 项数据指标。

一、基础信息

医保结算清单是按病种付费数据采集和经办管理的重要基础。定点医疗机构应按照《医疗保障基金结算清单填写规范》等规定，如实填报患者诊疗、医疗收费等信息，并上传至医保信息平台。医保结算清单及相关数据，是制定分组方案、测算支付标准、开展结算清算、审核核查等工作的基础数据来源。

（一）成组的基础信息

DIP 需要的基础数据包括疾病的编码系统、资源消耗、治疗方式、病情严重程度及医疗状态等多个维度的信息，考虑到数据的准确性和可获得性，其均来自参保人的《医疗保障基金结算清单》，具体如表 2-1。

表 2-1 DIP 聚类成组相关基础信息

组合轴心	信息/数据	信息业务编码类别
疾病严重程度及特异性特征	主要诊断、相关诊断、并发症/合并症、个体因素（如年龄、性别等）	《医疗保障疾病诊断分类与代码（ICD-10）》（2.0 版） 《医疗保障手术操作分类与代码（ICD-9-CM-3）》
治疗方式的属性	保守治疗、诊断性操作、治疗性操作、相关手术	《中医疾病分类与代码》 《中医症候分类与代码》 《医保结算清单》填报口径

肿瘤严重程度	肿瘤转移、放化疗等，疾病发展阶段	
资源消耗	医疗费用（医保药品、耗材、医疗服务项目分类与代码）、住院天数	《医疗服务项目分类与代码》 《医保药品分类与代码》西药、中成药、中药饮片（颗粒剂）、医疗机构制剂 《医保医用耗材分类与代码》 《医保结算清单》填报口径
医疗结果	出院状态（死亡、医嘱出院、非医嘱出院、转院）	
医疗付费	医保支付、个人支付、支付方式	

（二）病人诊疗数据变量

1.基本信息。包括定点医药机构名称、定点医药机构代码、医保结算等级、医保编号、病案号、性别、出生日期、年龄、天龄（年龄不足1周岁）、患者证件类型、患者证件号码、职业、医保类型、特殊人员类型、参保地、新生儿出生体重、新生儿入院体重等。

2.住院诊疗信息。包括住院医疗类型、入院途径、治疗类别、入院时间、入院科别、转科科别、出院时间、出院科别、实际住院天数、门（急）诊诊断、出院诊断（主要诊断、相关诊断）、入院病情、诊断代码计数、手术及操作信息（主要手术及操作、相关手术及操作）、手术及操作代码计数、呼吸机使用时间、颅脑损伤患者昏迷时间、重症监护病房类型、进出重症监护室时间、离院方式、出院31天内再住院计划等。

（三）医疗收费信息数据变量

业务流水号、票据代码、票据号码、结算期间、金额合计、医保统筹基金支付、补充医疗保险支付、医疗救助支付、其他支付、个人自付、个人自费、个人账户支付、个人现金支付、医保支付方

式等。

二、填报口径

定点医疗机构应严格按照国家有关规定和统一要求填报医保结算清单，准确反映患者诊疗过程和医疗收费情况。填报应当做到真实、规范、完整、及时，确保能够满足按病种付费管理、结算清算和审核核查的需要。

医保结算清单中常用的标量、称量等数据项应当使用国家和医保、卫生行业等相关标准。其中，诊疗信息数据指标填报主要来自住院病案首页数据，医疗收费信息数据指标填报口径应与财政部、国家卫生健康委员会、国家医疗保障局统一的“医疗住院收费票据”和“医疗门诊收费票据”信息一致。

三、编码标准

各地应做好国家医疗保障信息业务编码标准应用工作，统一规范使用疾病诊断和手术操作、医疗服务项目、药品、医用耗材等信息业务编码标准。定点医疗机构应严格执行国家统一编码标准，为病种分组、支付标准测算和结算清算提供统一、规范的数据基础。

医保信息业务编码标准是新时期医保信息交换的“通用语言”。在定点医疗机构全面落地应用国家医保信息业务编码，包括医保疾病诊断和手术操作、医疗服务项目、药品、医用耗材等编码标准。

按照国家医保结算清单填写规范，医保结算清单中的西医疾病诊断代码统一使用《医疗保障疾病诊断分类与代码（ICD-10）》，手术和操作代码统一使用《医疗保障手术操作分类与代码（ICD-9-

CM-3)》，中医疾病诊断代码统一使用《医疗保障中医诊断分类与代码》，日间手术病种代码统一使用《医保日间手术病种分类与代码》。填写疾病诊断、手术及操作项目时应当同时填写名称及代码。

四、数据上传

定点医疗机构应按照协议要求，依托医保信息平台及时完成结算清单及相关数据的全量上传，确保数据全面、准确、及时，为按病种付费分组、测算、结算和监管提供支撑。

各地需建立数据上传流程，明确上传时限，根据定点医疗机构上传的医保结算清单，建立定点医疗机构结算数据，确认纳入 DIP 结算病例范围。

定点医疗机构应当严格按照医保结算清单填写规范的要求，规范填报住院服务的基础信息、诊疗信息、费用信息等，使用国家医保统一的疾病诊断编码版本，在病案归档的同时及时上传医保结算清单，确认上传数据总量及纳入 DIP 结算范围的病例数据。

五、审核治理

各地应加强数据治理，开展医保结算清单相关的数据质量控制工作，按照规定对上传数据进行核验，提高数据质量。要加强清单质控和数据治理，为按病种付费提供可靠依据。数据治理中，应基于对病案首页信息、出院小结等相关诊疗行为的对照核验，着重发现和纠正结算清单填报不规范、上传不及时、编码不准确等问题，持续提升数据质量。

填写医保结算清单时需依据医保的结算要求，客观、准确、完

整、规范、及时填写反映患者诊疗、医疗收费等信息。各地应制定并应用医保结算清单校验规则，通过信息系统的智能校验，加强全流程数据质控。同时，应聚焦医保结算清单填报的常见问题，引导医疗机构填写规范，提高数据质量，夯实数据基础。

（一）准备工作

1.建立 DIP 模式下的医保结算清单质量管理制度

在 DIP 模式下，医保结算清单的质量控制主要基于医保结算清单规范和临床知识库。根据医保结算清单信息生成过程，明确各环节、各板块清单内容质控的职责划分，确保医保结算清单质控的可操作性，制定适合实际情况的医保结算清单质控管理流程。

2.制定 DIP 模式下的医保结算清单质量管理目标

在 DIP 模式下，各地应根据医保结算清单质控的标准及要求，制定医保结算清单质量管理总体目标。建立健全医保结算清单质量控制指标评价体系，制定包括但不限于及时性、完整性、合理性及规范性四个维度的数据审核指标以及针对违规行为监管的医保结算清单指数，包括合规性指数、编码高套指数、编码低套指数等，通过制定各项管理目标值监控医保结算清单数据质量并进行持续性工作改进。

（二）具体实施

1.DIP 模式下的医保结算清单数据质量控制

医保结算清单质控的重点包括：入院途径、入院时间、入院科别、转科科别、出院时间、出院科别、实际住院天数、门（急）诊

诊断、出院诊断、入院病情、手术及操作信息、麻醉方式、离院方式等。其中“疾病诊断+治疗方式”为 DIP 成组的核心依据，住院医疗类型出院诊断及手术及操作信息的准确完整规范是清单质控的重点任务。

医保结算清单质控工作方式包括但不限于：

（1）制定《医保结算清单质量控制评分表》，对清单项目内容按重要性赋予权重分值，由清单质控人员进行核查评分。

（2）对医保结算清单重点、易错项目进行专项质控。对某些病种或手术操作进行专题清单质控。

（3）对某类特殊人群（新生儿、死亡病人、产妇、肿瘤病人）进行专题清单质控。

（4）借助信息化手段完成对医保结算清单项目的逻辑校验、非空校验等基础性工作，确保医保结算清单数据的完整合规，以智能化工具辅助医保结算清单质控工作。

2.医保结算清单质控人员的培养和考核

建立健全医保结算清单质量管理人员的培养和考核制度。医保结算清单质控人员应充分了解各评价管理体系的相关规定，并严格遵照管理要求完成质控工作。各地应定期对从事医保结算清单质控的人员进行医保结算清单填写规范及相关管理要求和法律法规的培训及考核。

3.医保结算清单质控定期总结及反馈

各地应当运用医疗质量管理工具开展医疗质量管理与评价，对

医疗机构医保结算清单质量管理要求执行情况进行定期总结及反馈，并建立相应的考核奖惩制度，不断优化医保结算清单质量管理流程，促进医保结算清单管理的双向循环，保证医保结算清单质控效果。

（三）审核内容

数据审核是在数据采集端的质量控制，主要考核三个维度，即及时性、完整性、准确性。

1.及时性。应在规定时间内完成数据上传，满足医保结算的需要。例如要求定点医疗机构在医保患者出院后（一般7日内）及时完成病案审核归档，严格按照医保结算清单填写规范要求形成医保结算清单，并实时上传。

2.完整性。依据医保结算清单和DIP有关医疗统计数据填报必填项和条件必填项要求，确保上传的数据必填项目完整填报。例如疾病诊断名称、疾病诊断代码、手术及操作名称、手术及操作代码、总费用、医疗机构名称、出生日期、入院日期、出院日期、年龄、性别等核心指标无漏项。

3.准确性。根据医保结算清单数据接口技术标准，上传的数据客观、准确反映患者诊疗、医疗收费等信息，并使用逻辑校验规则。例如规范、准确应用医疗保障疾病诊断分类与代码、医疗保障手术操作分类与代码等信息业务编码标准；性别与诊断、年龄与诊断的相符判断；出入院时间的逻辑判断；诊断与手术的逻辑判断；总费用与明细费用的逻辑判断；诊断与费用的逻辑判断等。

经审核发现问题时，需及时反馈给定点医疗机构，在条件允许

的情况下，进行数据的重新采集。其中，定点医疗机构在规定时间内根据反馈问题修订医保结算清单并重新上传，在确保符合临床实际的前提下，提高数据的上传率、入组率、准确率，形成闭环循环质控机制。

此外，在审核结算清算时，根据 DIP 病种库进行病例入组匹配，运用智能审核、人工审核、专家评审等方式进行可疑数据的筛查及违规行为确认，对确认为合理医疗行为的病例正常纳入 DIP 结算；对确认为不合理医疗行为的，不纳入 DIP 结算。

（四）数据清洗

数据治理是在数据采集源无法改善优化的条件下，为保证数据测算相对准确合理，从病例数据的住院日、住院费用、年龄、编码等方面，出于逻辑性、合理性等考虑而设置清洗规则，对数据进行常规清洗和质量优化后应用于成组或病种分析。

1.规范性问题的治理。当诊断代码出现不规范，可以结合诊断名称或诊断说明，以及与标准代码目录的映射，进行校验清洗；当手术操作代码出现不规范，可以结合手术操作名称或说明，以及与标准代码目录的映射，进行校验清洗。

2.合理性问题的治理。当患者性别或年龄与诊断出现矛盾，或者出入院时间出现矛盾时，可以结合结算清单其他变量，进行逻辑分析后，进行校正；当总费用与明细费用出现矛盾时，可以结合医保明细数据进行费用层面的校验。

第三节 支付方式管理子系统

为保障 DIP 系统的统一性、规范性、科学性、兼容性以及信息上下传输的通畅性，国家医保局发布全国统一的支付方式管理子系统下设 DIP 成组与付费信息化系统基本功能规范，成为支付方式管理子系统的组成部分。支付方式管理子系统 DIP 功能模块架构包括“一个系统、二级部署、三级配置和终端应用”四个方面。各地在实施时按照基础约束类子系统的要求落实基本功能规范，在已有功能应用尽用的基础上，结合实际予以细化或充实，实现 DIP 系统与定点医疗机构信息系统的交互和数据业务协同。

一、系统功能

各地应加快全国统一的医保信息平台落地应用，完善数据采集、质量控制、分组方案管理、分组服务、权重（分值）和费率（点值）测算、结算清算、审核核查等功能，深化支付方式管理子系统 DRG/DIP 相关功能模块应用，为按病种付费管理提供数据和平台支撑。可结合实际推进智能审核、病例评审、运行监测等个性化配置，构建全流程线上管理体系。

按照国家统一平台支撑和统一标准规则的建设要求，基于全国统一的医保信息平台支付方式管理子系统 DIP 功能模块，在国家 and 省两级支付方式管理子系统中分别部署应用（部分省份按事先确定的架构实施国家、省、地市三级部署）。其中，国家局应用数据质控、国家病种库管理、地方病种库查询等功能，并通过开展支付方式管理子系统监测点建设工作，促进国家医保信息平台功能完善，

实现 **DIP** 所需数据在国家医保信息平台相关子系统全面、准确、及时抓取，实现国家医保信息平台子系统之间数据共享、交互应用。开展医保支付方式改革实时监测、统计分析、横向纵向比较、绩效评价、智能监管、可视化展示等，实现国家、省级层面支付方式改革的实时监测、比较、分析、评价。地方应用医疗机构支付方式配置与查询、质控规则维护与查询、国家病种库查询、地方病种库管理、支付方案维护、总额预算管理、月度拨付、年度清算、绩效考核、智能监管等功能。

二、地方系统维护

各地应指导定点医疗机构及时做好医保信息平台数据库动态维护、编码映射、接口改造等工作，保障按病种付费相关数据采集、传输、分组、测算和结算清算等业务正常开展。地方开展系统维护时，应坚持与全国统一医保信息平台衔接一致，满足按病种付费业务需要。

根据《国家医疗保障局办公室关于做好支付方式管理子系统 **DRG/DIP** 功能模块使用衔接工作的通知》（医保办函〔2022〕19号）的要求，**DIP** 改革地区依托国家医保局全国统一的医保信息平台支付方式管理子系统 **DIP** 功能模块，结合地方实际建设与 **DIP** 付费工作相适应的信息系统，开展医保信息业务编码数据库动态维护、编码映射，以及定点医疗机构有关接口改造等工作，发挥信息标准化在医保支付管理中的支撑作用。具体包括医保业务及需求调研、历史数据采集与治理、系统功能模块的政策参数配置及部署、**DIP** 业

务标准规范制定、模拟付费运行准备、系统测试联调改进、试运行及正式上线等步骤。

三、信息交互要求

地方版 DIP 病种库要通过支付方式管理子系统上传到国家端，实现地方分组方案、入组结果、支付标准等可查询。各地应做好医保信息平台相关模块之间的信息衔接和数据交互，保障按病种付费基础数据、分组结果、支付标准和结算结果贯通应用。

按国家局要求落地使用支付方式管理子系统 DRG/DIP 功能模块基础功能，结合本地实际设置支付方式管理子系统 DIP 功能模块的规则、参数，并做好与国家平台的对接、传输等信息交互工作。一是在病种组合、月度结算环节，确保地方 DIP 病种库、结算规则能够导入省级医保信息平台。二是在年度清算环节，需与全年月度预结算金额、预拨周转金、年度考核结果、审核扣款等相关数据衔接，同时确保与收费端系统的相应数据有信息交互。

四、数据使用模式

各地应依托医保信息平台支付方式管理子系统 DRG/DIP 相关功能模块，结合地方实际开展按病种付费分析和评价。统筹地区应建立数据工作组，定期分析医保基金收支情况、预算执行情况、DRG/DIP 付费、结算清算进度等，按月向医疗机构公布数据，暂不具备条件的可按季度公布。数据采集、传输和使用应符合国家相关法律法规和数据安全管理要求，保障数据安全可控。

根据《关于进一步明确市县级数据应用模式的通知》（医保网

信办〔2022〕12号）的精神，省级医保部门要建立数据安全管理和使用等制度，并将市县级的数据应用模式明确规范为三种类型，由省级医保部门根据本地实际情况进行选择。一是省级医保部门在国家统一的医保信息平台前台开放用户权限，满足市县级医保部门数据应用需求。二是省级医保部门对数据库进行分区、分库、分表处理，开放只读数据查询库使用权限，满足市县级医保部门对本地数据的应用需求。三是省级医保部门应按要求设立市县应用“专区”，由市县级医保部门在“专区”中进行数据应用。其中，要求将后两种模式逐步转换到第一种模式。

第三章 病种分组

第一节 成组原理

病种成组的核心是建立病种组合（Case-Mix），将诊断相同、临床过程相似、资源消耗相近的历史病例进行打包组合。按照大数据理论，DIP 通过分析真实世界的历史数据，形成疾病诊断与治疗方式的病种组合。结合该病种组合内所有病例的平均资源消耗，按照卫生经济学的一般均衡理论不断探寻收入与成本之间的关系，以确定支付标准。病种成组是能否实现科学付费的关键环节。

一、成组原则

（一）依据历史数据

病种成组以前三年历史数据为基础，综合反映区域内疾病治疗、医疗服务发展趋势。

（二）符合临床规律

将意见收集、临床论证和数据分析相结合，以保证病种组合符合临床实际，促进医疗机构规范诊疗，合理消耗医疗资源。既体现临床实际，又给予必要校正。

（三）病种单元适宜

病种单元的适宜性主要考量病种组合的颗粒度和病例的离散程度，需符合病种组内资源消耗差异小、组间资源消耗差异大的特点，既客观体现病种的实际资源消耗，又防范组间高套或低套的风险。

（四）病种覆盖全面

DIP 以核心病种为主要付费单元，综合病种作为补充，基本实

现普通住院疾病的全覆盖。

各地病种数量多少与人口数、疾病谱、医疗技术水平等相关。

二、基本类别

DIP 病种库包括核心病种和综合病种。其中，病例数达到临界值以上的病种组合归入核心病种，作为 DIP 结算的主要付费单元；病例数未达到临界值的病种组合，可纳入综合病种管理。病例数临界值应依据国家技术规范，结合当地实际情况确定。

（一）核心病种

核心病种是基于可显著区分资源消耗程度的诊断及治疗方式，使用历史病案的医保版疾病诊断代码和手术操作代码，按照“主要疾病诊断+主要手术操作（+相关手术操作）”的规则组合形成的病种。按照覆盖病例数达到一定占比的（如 95%）的原则，或病例数达到固定临界值的，聚类形成核心病种，成为 DIP 付费的主要单元。

（二）综合病种

综合病种是指按照“主要疾病诊断+主要手术操作的具体属性”聚类形成的病种，依据治疗方式的具体属性聚类成组，即将历史数据穷举聚类形成的病种组合中，病例数在临界值以下的病种覆盖病例数较少，需再次进行收敛，作为核心病种付费单元的补充。相关病种组合示例详见表 3-1。

表 3-1 综合病种组合示例

组别	主要诊断代码	主要诊断名称	主要操作代码	主要操作名称	相关操作代码	相关操作名称	历史病例数	DIP 组合
1	C54.1	子宫内膜恶性肿瘤	68.4902	经腹筋膜外全子宫切除术	.	.	14	→聚类为综合病种 “C54 子宫

2	C54.1	子宫内 膜恶性 肿瘤	68.4101	腹腔镜经 腹子宫扩 大切除术	.	.	8	体恶性肿 瘤，相关手 术组”
3	C54.1	子宫内 膜恶性 肿瘤	68.4101	腹腔镜经 腹子宫扩 大切除术	65.6300	腹腔镜双 侧卵巢和 输卵管切 除术	13	
4	C54.9	未特指 的子宫 体恶性 肿瘤	68.4901	经腹全子 宫切除术	.	.	10	

（三）临界值

设置病例数临界值，用于区分核心病种与综合病种。病例数临界值的确定可结合当地情况，在如下方法中选择：一种是设定固定值。固定值的设置应综合考虑当地参保人口/常住人口、发生住院病例总量等基本因素。省级（含自治区、直辖市，下同）统筹区确定临界值应明显高于一般地市级统筹区。如一般地市级统筹区以 15 例为临界值，省级统筹区应至少在 50 例以上。另一种是结合当地病例数据的规模进行测算，以达到临界值以上的病例数能覆盖一定比例（如大于等于 95%）来设定。

三、成组规则

DIP 按照“诊断+操作”的基本规则，将真实、全量历史医保结算清单数据聚类形成病种，同一诊断下以不同的操作形成不同的组别，精准反映某个病种组合的疾病严重程度、资源消耗水平以及临床行为特征。示例见表 3-2。

表 3-2 核心病种成组示例

病种	主要诊断代码	主要诊断名称	主要手术操作代码	主要手术操作名称	相关手术操作代码	相关手术操作名称	患者人次	次均费用(元)
病种 1	K35.9	急性阑尾炎	.	无手术操作 (保守治疗)	.	.	6722	4099
病种 2			47.0901	阑尾切除术	.	.	7120	9173
病种 3			47.0100	腹腔镜下阑尾切除术	.	.	12103	13385

同时，在对存在“相关手术操作”，且相关手术操作资源消耗达到该病例原费用 10%以上的情形单独成组。即由“主要诊断+主要手术操作+相关操作”形成的独立的病种，示例见表 3-3。

表 3-3 相关操作资源消耗的病种组别示例

病种	主要诊断	主要诊断名称	主要操作名称	相关操作名称	次均费用(元)	次均费用增幅	是否保留为相关操作
病种 1	I21.0	前壁急性透壁性心肌梗死	药物洗脱冠状动脉支架置入	.	28033	.	.
病种 1	I21.0	前壁急性透壁性心肌梗死	药物洗脱冠状动脉支架置入	用两根导管的冠状动脉造影术	28849	2.91%	否
病种 2	I21.0	前壁急性透壁性心肌梗死	药物洗脱冠状动脉支架置入	冠状动脉血管内超声	44003	56.97%	是

由此，以病种作为付费单元，具有“一病一操作一组”及组内医疗资源消耗差异较小等特点。在此基础上，按照病例数临界值的方式区分核心病种、综合病种。

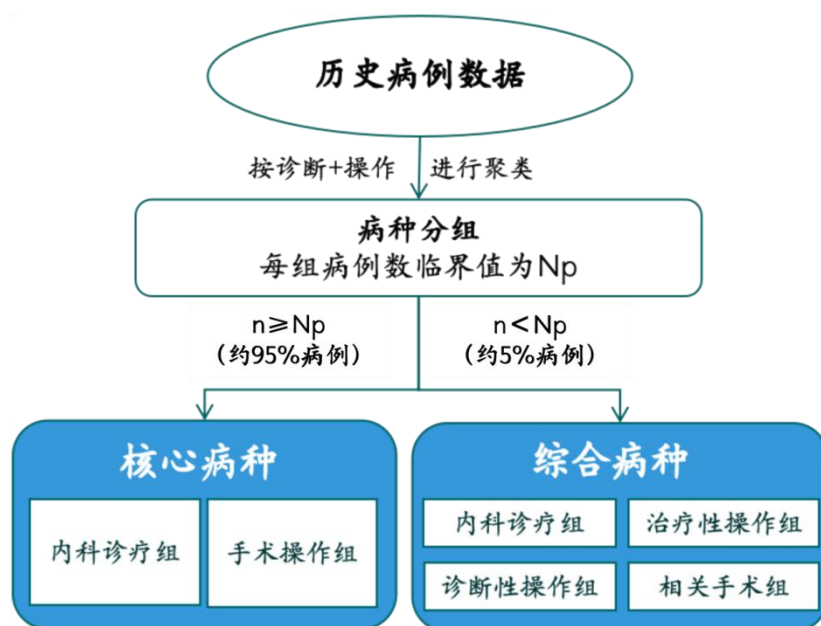


图 3-1 DIP 病种成组示意图

本次 DIP3.0 版调整，在保持基本规则不变的前提下，增加了先期分组下的核心病种、并项规则下的核心病种、相关诊断辅助细分下的核心病种等。

第二节 成组规程

DIP 聚类组合主要包括：采集历史病例数据、聚类形成核心病种、形成综合病种、组织开展临床论证、最终确定本地病种库。其中，国家病种库不设定综合病种，地方病种库设综合病种。现将国家病种库核心病种成组规程介绍如下：

一、历史数据采集及治理

各地依托全国统一的医保信息平台采集医保结算清单、医疗费用明细等相关数据，按照一定质控规则对数据进行清洗、处理，形成基础数据库，作为病种分组基础。地方在开展病种成组时，应当依照国家统一规则和技术规范，做好本地历史数据采集、质控和治

理工作，为形成地方病种库提供可靠依据。

采集本地区近三年职工医保、城乡居民医保患者的全部出院相关历史数据，按照数据质控规则对历史数据进行清洗、处理，形成DIP病种组合的基础数据库。在开展病种分组前，依据相关指南和规范，制定编码排除规则，包括列出不能作为主诊断的ICD-10疾病编码排除表，以及不宜纳入分组规则的ICD-9-CM-3手术操作编码排除表，以提高分组的规范性与准确性。

二、意见收集反馈机制

各级医保部门应建立常态化意见收集反馈机制。可通过线上线下多种形式，收集医疗机构和一线医务人员对支付政策、技术规范、分组方案、信息化建设、编码标准等方面的意见建议。按照属地化管理原则，分级分类做好按病种付费意见收集、反馈和汇总上报工作。定点医疗机构应建立本单位意见收集机制，定期向统筹地区医保部门提交意见建议。

三、形成核心病种

地方形成核心病种时，应以国家病种分组方案和技术规范为基础，结合本地历史数据，按照国家统一的DIP病种成组规则确定核心病种。核心病种为本地DIP结算的主要付费单元，其范围和规则应与国家要求保持一致。

按聚类规则达到临界值以上的同类病例形成核心病种。根据资源消耗和病种组合顺序分为先期分组下的核心病种、并项规则下的核心病种、相关诊断辅助分组下的核心病种和基本规则下的核心病种等四大类。其流程包括：排除列表对照、先期分组下的核心病种、

并项规则下的核心病种、相关诊断辅助细分下的核心病种、基本规则下的核心病种。

（一）先期分组下的核心病种

考虑到部分疾病或诊疗技术消耗医疗资源较大、对分组整体效能影响显著，为保证病种分组的科学性与稳定性，对此类病例实行先期分组，并单独制定支付标准。先期分组主要包括各类器官移植、呼吸循环支持、低出生体重儿等几大类，先期分组多不区分主要诊断，依靠主要手术操作及其他分组条件进行分组。如下表所示：

表 3-4 先期分组示例

先期分组代码	先期分组名称	分组规则	主要诊断代码	主要诊断名称	主要手术操作代码	主要手术操作名称	其他条件
AA1	心肺移植	包含主要手术操作之一	所有诊断	所有诊断	33.6x00	心脏-肺联合移植术	.
AA2	心脏移植	包含主要手术操作之一	所有诊断	所有诊断	37.5100/37.5100x001	心脏移植术/自体心脏移植	.
AI1	超低出生体重儿	主要诊断+天龄<29天+出生体重<750克	P07	与孕期短和低出生体重有关的疾患，不可归类在他处者	.	.	天龄<29天且出生体重<750克
AI2	超低出生体重儿	主要诊断+天龄<29天+出生体重750-999克	P07	与孕期短和低出生体重有关的疾患，不可归类在他处者	.	.	天龄<29天且出生体重750-999克
AI3	极低出生体重儿	主要诊断+天龄<29天+出生体重1000-1499克	P07	与孕期短和低出生体重有关的疾患，不可归类在他处者	.	.	天龄<29天且出生体重1000-1499克
AI4	较低出生体重儿	主要诊断+天龄<29天+出生体重1500-	P07	与孕期短和低出生体重有关的疾患，不可	.	.	天龄<29天且出生体重1500-1999克

		1999 克		归类在他处者			
AI5	低出生体重儿	主要诊断+天龄<29 天+出生体重 2000-2499 克	P07	与孕期短和低出生体重有关的疾患，不可归类在他处者	.	.	天龄<29 天且出生体重 2000-2499 克

（二）并项规则下的核心病种

并项规则下的核心病种是指为提升分组效能、减少套编空间、实现支付结果公平，对原有基本核心病种通过合并相似诊断/手术操作（并项）形成的核心病种。具体规则如下：

1. 诊断并项

对手术操作路径相似、资源消耗相同或相近的部分诊断，在 3 位诊断码下进行归并。如：

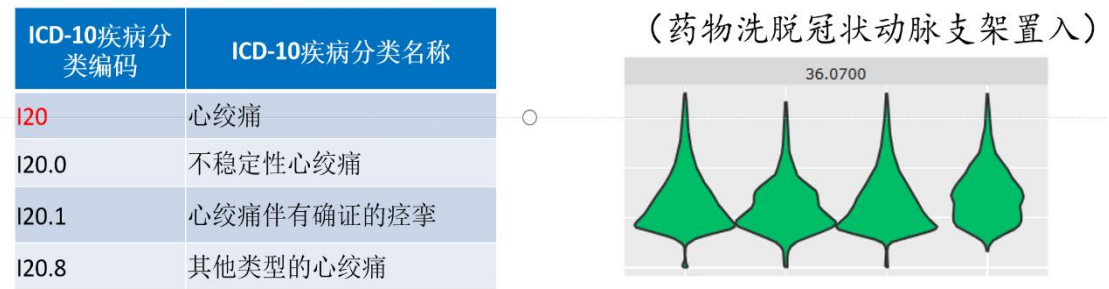


图 3-2 心绞痛药物洗脱冠状动脉支架置入相关诊断并项示例

2. 手术操作并项

（1）第一类手术并项：对在一次手术过程中，由临床专家完成多个不同术式的联合操作，进行合并成组，确保此类临床资源消耗在分组中得以独立、明确体现。如同期住院，符合临床诊疗规范的相关手术病种。

表 3-5 第一类手术并项示例

疾病诊断 代码亚目	疾病诊断 名称	主要手术 操作代码	主要手术 操作名称	相关手术 操作代码	相关手术操作 名称
--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

E11.3	2 型糖尿病伴有眼的并发症	13.4100x001	白内障超声乳化抽吸术	13.7100x001	白内障摘除伴人工晶体一期置入术
M75.1	旋转袖综合征	81.8300x008	肩关节镜下肩袖修补术	80.7101	关节镜肩关节滑膜切除术
I83	下肢静脉曲张	38.5900x010	大隐静脉射频消融术	38.5901 38.5903	大隐静脉高位结扎和剥脱术 大隐静脉曲张剥脱术

(2) 第二类手操并项：对手术操作在技术难度、风险等级、操作目标上高度相似的，进行并项，即把此类情况作为同样分值的组别。如同类疾病，临床治疗方式相同且资源消耗接近的手术操作进行合并。

表 3-6 第二类手操并项示例

诊断代码	诊断名称	主要手术操作代码	主要手术操作名称
D18.0	血管瘤，任何部位	21.0300x003 21.0300x004 21.0302	鼻内窥镜下鼻微波烧灼止血术 鼻内窥镜下电凝止血术 鼻出血电凝术
D18.0	血管瘤，任何部位	21.3104 21.3106 21.3109	内镜下鼻内病损切除术 内镜下鼻内病损破坏术 内镜下鼻内病损射频消融术
D18.0	血管瘤，任何部位	29.3900x007 29.3905 29.3906 29.3907 29.3908 29.3909	支撑喉镜下鼻咽病损切除术 支撑喉镜下咽部病损切除术 支撑喉镜下咽部病损激光切除术 支撑喉镜下咽部病损射频消融术 内镜下鼻咽病损切除术 内镜下梨状窝病损切除术
D18.0	血管瘤，任何部位	30.0907 30.0909	内镜下声带病损射频消融术 内镜下喉病损射频消融术
D18.0	血管瘤，任何部位	39.7903 39.7904	经导管肝动脉栓塞术 经导管脾动脉栓塞术

3.恶性肿瘤多模式联合治疗病种组合

放疗、化疗、靶向治疗、免疫治疗等两种或两种以上治疗方式联合进行治疗设立相关病种组合。

【关于肿瘤疾病的病种组合说明】

对于历史数据中的肿瘤病例，按以上规则聚类形成内科诊疗组、手术操作组。手术操作组中，诊断和操作需准确且符合直接对应逻辑，例如“肿瘤疾病诊断+肿瘤手术操作”“化疗诊断+化疗操作”“放疗诊断+放疗操作”等。

此外，由于肿瘤疾病治疗的复杂性，存在采用多种治疗方式联合治疗的病例（联合方式如手术+化疗、放疗+化疗、免疫治疗+化疗等，难以穷举），在形成核心病种时，可不以具体病种体现。对于当年发生的该类病例，建议基于核心病种，可通过肿瘤严重程度分型调节系数体现资源消耗差异，或可对联合其他治疗方式的病例进行分值追加，追加程度可结合数据测算和临床论证确定。

手术+化疗、放疗+化疗联合治疗示例：

组别	主要诊断代码	主要诊断名称	主要操作代码	主要操作名称	相关操作代码	相关操作名称	可追加分值的联合治疗方式示例
1	C54.0	子宫峡部恶性肿瘤	68.4100	腹腔镜经腹全子宫切除术	65.6300	腹腔镜双侧卵巢和输卵管切除术	“99.2503 静脉注射化疗药物”或“99.25 注射或输注肿瘤化学治疗物质”
2	Z51.0	放射治疗疗程	92.2400x003	调强适形放射治疗[IMRT]	.	.	

（三）诊断辅助细分下的核心病种

基于疾病编码填报规则，部分病种的主诊断不能完全反映患者疾病或诊疗技术的医疗资源消耗情况，须同时填写相关诊断予以辅助，为保证 DIP 分组的科学性和支付标准的精准性，对部分病种组合设立相关诊断辅助分组。

1. 烧伤类病种

临床论证专家建议结合临床实际先使用烧伤面积、再使用烧伤程度进行分组，考虑到烧伤面积不能作为主要诊断，进一步优化专

家建议，先区分年龄（成人、儿童），再按照“主要诊断（程度：区分是否多部位）+次要诊断（面积）”的分组规则进行分组。

2.肿瘤类病种

针对不同类型复治恶性肿瘤，存在采用化疗、靶向、免疫等不同治疗方式联合治疗的病例，比如可分为化疗、化疗+靶向、化疗+靶向+免疫等不同组合。在不同治疗方式组合下，根据“主要诊断+相关诊断”的方式区分实体瘤、血液病、淋巴瘤等不同肿瘤类型，进一步体现资源消耗差异。如主要诊断为“为肿瘤化学治疗疗程”（Z51.1），治疗方式为“化疗+靶向”，使用“不明确、继发和部位未特指的恶性肿瘤”或“淋巴瘤”或“白血病”等相关诊断，可以区分出该病例属于实体瘤、血液病还是淋巴瘤。如下表所示：

表 3-7 复治恶性肿瘤化疗使用相关诊断辅助分组示例

主要诊断 代码	主要诊断 名称	次要诊 断代码 范围	次要诊断名称	治疗方式
Z51.1	为肿瘤化学 治疗疗程	C00-C75	特指部位述及或假定为原发性 的恶性肿瘤，除外淋巴、造血 和有关组织	化疗
		C00-C75	特指部位述及或假定为原发性 的恶性肿瘤，除外淋巴、造血 和有关组织	化疗+免疫
		C00-C75	特指部位述及或假定为原发性 的恶性肿瘤，除外淋巴、造血 和有关组织	化疗+靶向
		C00-C75	特指部位述及或假定为原发性 的恶性肿瘤，除外淋巴、造血 和有关组织	化疗+靶向+免疫
		C91-C95	白血病	化疗
		C91-C95	白血病	化疗+免疫
		C91-C95	白血病	化疗+靶向

主要诊断 代码	主要诊断 名称	次要诊 断代码 范围	次要诊断名称	治疗方式
		C91-C95	白血病	化疗+靶向+免疫

3.结核类病种

结合临床实际对部分情况按更加细化的诊断进行分组。即对于少数因轻重程度导致资源消耗差异显著的病种，通过精准拆分提升分组的颗粒度与适配性。典型的是耐药性结核病和非耐药性结核病，两者治疗用药、疗程、费用、预后差异均较大，3.0 版本通过诊断细分（拓展码）的方式将耐药性结核病单独成组。

（四）基本规则下的核心病种

基本规则下的核心病种为根据病例历史数据，采用“主要诊断+主要手术操作（+相关手术操作）”基本规则聚类形成的病种。分为内科诊疗病种、手术操作病种，基本规则下的核心病种是病种库的主体，占核心病种的绝大部分。具体规则如下：

1.内科诊疗病种

对于未包含手术及操作或仅包含简单操作的病例，根据主要诊断 4 位码聚类形成相应的核心病种（表 3-8 中的组别 1、组别 2）。

2.手术操作病种

（1）主要诊断+主要手术操作

对于针对主要诊断的病症施行常见手术或操作的病例，按照主要诊断 4 位码+主要手术操作聚类形成相应的核心病种（表 4-8 中的组别 3、组别 4、组别 5）。其中，主要手术操作以风险最大、难度最高、花费最多为特征。

（2）主要诊断+主要手术操作+相关手术操作

对于同时实施资源消耗较大的相关手术或操作的病例，按照主要诊断 4 位码+主要手术操作+相关手术操作聚类形成相应的核心病种（表 3-8 中的组别 6）。

表 3-8 不同类型核心病种组合示例

组别	主要诊断代码	主要诊断名称	主要操作代码	主要操作名称	相关操作代码	相关操作名称
1	K35.3	急性阑尾炎伴局限性腹膜炎	.	.	.	.
2	C34.1	上叶，支气管或肺的恶性肿瘤	.	.	.	.
3	K35.3	急性阑尾炎伴局限性腹膜炎	47.0100	腹腔镜下阑尾切除术	.	.
4	K35.3	急性阑尾炎伴局限性腹膜炎	47.0901	阑尾切除术	.	.
5	C34.1	上叶，支气管或肺的恶性肿瘤	32.3001	胸腔镜下肺叶部分切除术	.	.
6	C34.1	上叶，支气管或肺的恶性肿瘤	32.3001	胸腔镜下肺叶部分切除术	32.2001	胸腔镜下肺楔形切除术

四、开展临床论证

国家版病种分组方案是在收集汇总医疗机构意见建议、以医保结算真实数据为基础，并通过临床论证、数据验证和征求相关部门意见后形成的。地方在落实国家病种分组方案、形成和调整本地病种库过程中，也应按照国家技术规范要求，结合本地实际，开展必要的临床论证和数据验证，确保分组结果科学合理。

收集并汇总整理本地区定点医疗机构对 DIP 成组结果的意见建议。组织临床、病案、编码、统计、信息和医保管理等方面专家，对 DIP 成组结果的科学性、规范性、合理性开展临床论证，具体可按临床专业领域依次分别进行。论证内容包括诊断、手术及操作的

逻辑匹配性，编码规范性，应用可行性，现有病种组合是否符合临床使用需求等。医保部门需做好政策宣传，加强多方沟通协商，就论证目的、要求等与专家达成共识，针对具体病种形成论证意见，进行修订完善。

第三节 国家病种库和地方病种库

病种库是 DIP 的应用基础，是指以医保住院结算数据为基础，按照“主要诊断+主要操作”为基础规则对住院病例进行聚类分组，反映疾病诊断与治疗方式的一般规律所形成的病种组合。

病种库包含各病种的主要诊断代码、主要诊断名称、主要操作代码、主要操作名称、相关操作代码、相关操作名称等信息。按照基础数据来源范围和功能作用不同，DIP 病种库分为国家病种库、地方病种库。病种库需要定期更新。

DIP 病种库包括核心病种和综合病种。通过设置病例数临界值区分核心病种与综合病种，病例数达到临界值以上的病种组合归入核心病种，作为 DIP 结算的主要付费单元。病例数临界值基于国家技术规范，结合当地实际情况确定。

一、国家病种库

国家医保局负责制定和调整国家版病种分组方案。根据医保管理要求和医疗服务实际需要，基于对按病种付费理论的研究，结合收集汇总医疗机构反映的意见建议，以医保结算真实历史数据为基础，通过临床论证和数据分析验证，征求相关部门意见后，形成国家病种库。按 DIP 分组规则形成的病种库，则形成国家层面的 DIP

病种库。

（一）定义

DIP 国家病种库是指由国家医疗保障局组织，采集全国范围医保住院结算数据，依据统一的“主要诊断+主要操作”规则对住院病例进行聚类分组所形成的病种组合目录。国家病种库是地方病种库形成的基础，对地方病种库的建立具有规范作用。

（二）版本更新

1. 1.0 版本与 2.0 版本

DIP 试点工作之初，以上海、广州等地区的前期工作为基础，叠加东、中、西部具有典型代表性的 10 个省市数据，使用疾病诊断代码和手术操作代码进行聚类，形成国家病种库（1.0 版）。1.0 版国家病种库核心病种 11553 组。

随着 **DIP** 改革深化和医疗新技术的应用，通过采集全国 **DIP** 支付方式改革地区 2020-2022 年医保结算清单，并优化了分组规则，对部分病例进行合并，对相关手术操作资源消耗差异达到 10% 以上的病例进行单独成组，于 2024 年颁布了 **DIP** 国家病种库（2.0 版）。2.0 版国家病种库核心病种 9520 组。

2. 3.0 版本

基于对 **DIP** 付费研究的不断深入，以及各地实施经验的不断积累，**DIP3.0** 版在保持分组基本规则不变的基础上，注重与 **DRG** 分组方法的优势互补，积极探索 **DRG/DIP** 融合路径，进一步提升分组的科学性与适用性。

3.0 版以 2023-2025 年全量病例数据为基础，广泛听取编码专家、临床医生及地方医保部门意见建议，通过大数据自动聚类成组，结

合临床合理性评价，汇集各方共识，确保分组结果既反映数据规律又符合临床实际。在具体规则优化上，通过设置排除列表、先期分组、诊断并项、手术操作并项以及诊断辅助细分等规则，使分组流程更加清晰，病种颗粒度更加适宜，更精准体现医疗资源消耗差异。通过分组规则的系统调整，有效解决了组间差异过小、部分病种颗粒度过细或过粗等问题，使病种组合更加契合临床实际、适应医保管理。

表 3-9 3.0 版国家病种库按操作属性分类表

3.0 版国家病种库	数量（组）
先期分组下的核心病种	18
并项规则下的核心病种	666
诊断辅助细分下的核心病种	78
基本规则下的核心病种	4289
共计	5061

二、地方病种库

省级和统筹地区医保部门做好病种分组方案落地。符合成组条件的病种，应直接采用国家病种库包含的病种。不符合成组条件的其他病例，按照国家层面 DIP 成组规则予以成组，作为地方增补病种。有条件的省份可以国家病种库为基础建立省级病种库，并作为各地市级统筹区分组的基础。

（一）定义

地方病种库是指基于国家层面 DIP 成组规则和技术规范，采集地方医保住院结算数据，对住院病例进行聚类分组所形成的病种组

合。

（二）与国家病种库关系

各地病种库应包括核心病种、综合病种（同时可根据需要设立基层病种、中医优势病种等）。地方病种库核心病种绝大多数应在国家病种库范围内，对于因地方特殊原因超出国家病种库范围的病种，经专家论证确需增补的，须严格控制比例并在本地病种库中予以标识，并向国家 DIP 技术指导组报备增补情况。地方病种库要全面上传国家医保信息平台，支撑医保支付、基金监管、医院管理等方面的应用。同时，要及时向本地定点医疗机构发布。

三、地方病种库成组

地方病种库分为核心病种库和综合病种库两类。核心病种库应当以国家病种库为基础，在坚持 DIP 病种成组规则与国家一致的前提下，结合本地历史数据对照形成。综合病种库分为内科诊疗组、诊断性操作组、治疗性操作组、相关手术组，对未纳入核心病种历史病例依据成组规程形成。

对于当年度纳入 DIP 结算病例，按照分别按照核心病种和综合病种入组规则，进行入组匹配，确定病例所属的病种，以确定相应支付标准，用于医保结算。

（一）核心病种成组

地方历史数据基础按照分组规则，首先对照国家核心病种库，按照地方确定的病例数临界值以上的病种依次形成基于国家病种库的地方核心病种。地方核心病种入组顺序与前述国家病种库一致。即对照排除列表（不能作为分组依据的诊断、操作列表）进行数据

处理、先期分组下的核心病种→并项规则下的核心病种→诊断辅助细分下的核心病种→基本规则下的核心病种。

病例主要诊断、主要操作和相关操作与国家核心病种库能完全匹配时成组。

病例主要诊断、主要操作能匹配国家核心病种库，但相关操作未完全匹配时，分为下列三种情形成组：

1. 优先纳入相关操作匹配数量最多的病种。

2. 若相关操作无法匹配相应病种，则纳入主要诊断+主要手术操作病种。

3. 当按照以上规则所匹配的病种存在两个或以上时，可由地方论证确定成组逻辑。

对于在对照过程中由于病例达不到临界值不能成组的病种，地方在分析相关病例组间差异情况后，对于病例资源消耗差异较小的，可适当降低临界值形成地方病种。

与国家病种库对照完成后，其余历史病例按照 **DIP** 病种成组规则，生成新增地方核心病种。对于此类超出国家病种库范围的病种，地方应首先排除历史病例病案填写、结算清单上传等错误原因后，经专家论证后予以增补，并在地方病种库中予以标识。

（二）综合病种成组

区域内病例数未达到核心病种临界值的病例，纳入综合病种进行管理和支付。综合病种可分为内科诊疗组、诊断性操作组、治疗性操作组、相关手术组，具体规则分为：

1. 内科诊疗组

将未包含手术及操作或仅包含简单操作的病种组合作为内科诊

疗组，按照主诊断类目（ICD-10 医保版前三位）进行聚类。

2.诊断性操作组

将主要操作（ICD-9-CM-3 医保版）属性为“诊断性操作”的组合，叠加主诊断类目（ICD-10 医保版前三位）进行聚类，形成诊断性操作组。

3.治疗性操作组

将主要操作（ICD-9-CM-3 医保版）属性为“治疗性操作”的组合，叠加主诊断类目（ICD-10 医保版前三位）进行聚类，形成治疗性操作组。

4.相关手术组

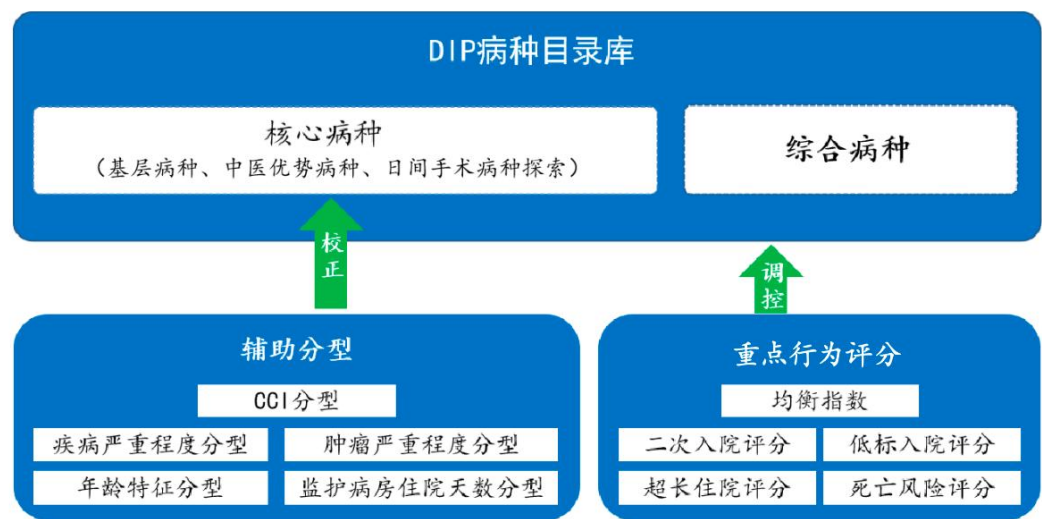
将主要操作（ICD-9-CM-3 医保版）属性为“手术”的组合，叠加主诊断类目（ICD-10 医保版前三位）进行聚类，形成相关手术组。

在形成综合病种时，还要注意：

（1）应适当控制综合病种的数量。对于聚类后病例数仍未达到临界值的病种，考虑其费用水平的不确定性较大，可予以剔除，避免成组过细和分值失准。

（2）需综合考虑组内变异系数应低于一定阈值，避免组内历史病例资源消耗差异大，影响病种组合的合理性。

各地可结合已有做法或开展协商论证，对 ICD-9-CM-3 手术操



作类别及属性进行确定。

（三）当年病例入组

对于当年度纳入 DIP 结算病例，应按照 DIP 数据要求进行清洗、编码排除后，对照地方病种库按“先核心病种、后综合病种”的顺序进行入组匹配，确定病例所属的病种，以确定相应支付标准，用于医保结算。

1.入组核心病种

核心病种入组顺序按照上述历史病例与国家病种目录库对照地方核心病种成组相同的规则开展当年病例入组。

对于入组过程中，由于相关操作引起资源消耗显著增加且病例数达到临界值及以上的情况，可按地方具体政策要求，在下一年度病种成组调整时进行新增，或在当年度使用发生的病例数据聚类形成病种经论证后进行补充。

2.入组综合病种

对于病例未入组核心病种的，主要诊断代码应匹配综合病种，以主要手术操作类型作为入组依据，分为下列四种情形：

- （1）当主要操作代码为手术或介入操作时，入组相关手术组。
- （2）当主要操作为治疗性操作，入组治疗性操作组。
- （3）当主要操作为诊断性操作时，入组诊断性操作组。
- （4）按上述规则均不能入组的病例归入内科诊疗组。

3.未入组病例

对于未纳入地方病种库当年病例，地方应制定相应结算办法，其支付标准应与入组病例结算保持适当差距。同时，地方应分析该类病例未入组原因，采取针对性措施提高病种入组率。对于地方新

技术应用、临界值因素等在国家核心病种库范围的病例，可以经当年病例数据聚类形成病种经论证后进行补充。

第四节 基层病种

一、定义与遴选原则

（一）定义

基层病种是核心病种中的一个类别。DIP 实施过程中，地方可根据本地实际情况，在适宜基层医疗机构开展且基层具备诊治能力的病种中，选取诊断明确、治疗方案成熟、临床路径清晰、医疗风险可控的一定数量病种，设为基层病种。设置基层病种，主要是引导三级医疗机构功能归位，多收治疑难危重症，发挥二级医疗机构在基层诊疗中的枢纽作用。有利于基层医疗机构服务能力提升和可持续发展，从支付机制上推动医疗资源下沉，切实促进“基层首诊”，助力分级诊疗落地。

（二）遴选原则

遴选基层病种时主要考虑：

- 1.以常见病、多发病、慢性病为主。
- 2.基层医疗机构病例占比较大。
- 3.医疗费用相对稳定，变异系数较低。如 CV 值不超过 0.7。

二、分值设定

对于基层病种，可不设医疗机构调节系数，即对该病种采用同一分值与医疗机构结算。

三、示例

基层病种多以内科诊疗组为主，如呼吸、消化系统等疾病相关病种。根据地方实际，部分涉及常规简单手术及操作的病种也可纳入（见表 4-9）。

表 3-10 基层病种示例

组别	主要诊断代码	主要诊断名称	主要操作代码	主要操作名称	相关操作代码	相关操作名称
1	A09.9	未特指病因的胃肠炎和结肠炎	.	.	.	.
2	B02.8	带状疱疹伴有其他并发症	.	.	.	.
3	I25.5	缺血性心肌病	.	.	.	.
4	I67.8	其他特指的脑血管疾病	.	.	.	.
5	J18.9	未特指的肺炎	.	.	.	.
6	K35.3	急性阑尾炎伴局限性腹膜炎	47.0901	阑尾切除术	.	.
7	K64.8	其他特指的痔疮	49.4600	痔切除术	.	.

第五节 病种动态调整

可依据客观数据采集、临床意见反馈、临床规律和数据特征变化和政策调整变化等，对病种成组进行维护和调整，调整内容为心病种、综合病种。

一、方案制定

方案制定应坚持总体稳定、动态优化的要求，既保持病种分组框架和基本规则的连续性，保障政策预期稳定，又针对分组过粗、分组过细、组合不合理、资源消耗倒置、编码适配性不足等问题，

有针对性地提出调整方向，提升病种分组的科学性、规范性和临床适配性。

方案制定应坚持国家统一规则与地方实际应用相衔接，明确国家病种库调整与地方病种库衔接的总体要求。对核心病种调整，应突出国家统一管理和统一规则；对综合病种调整，应为地方结合本地疾病谱、医疗服务供给和管理实际开展动态维护预留空间。方案经研究确定后，应作为后续数据分析、意见收集、临床论证、规则优化和地方应用衔接的总体依据。

二、调整程序

国家层面综合考虑临床技术发展、诊疗行为改变等因素，对核心病种进行动态调整，主要包括：

1.历史数据汇总。收集全国层面 2023-2025 年医保结算清单数据，通过数据质控后供成组分析。

2.专家全面研究。基于对 DIP 支付改革认识的深化和对改革实践经验的总结，技术指导组核心专家集中系统研究 DIP 分组规则的调整优化。既“积极应变”又“主动求变”，研究形成 DIP3.0 版分组调整规则，报请国家医保局审核。

3.意见收集分析。国家医保局建立常态化意见收集反馈机制，分级分类收集医保部门、医疗机构和一线医务人员对病种分组的意见建议。对其中具有代表性、共识度较高、数据支撑较充分的意见，纳入核心病种调整研究范围。

4.临床论证优化。围绕 3.0 版分组规则调整涉及的重点病种和前期收集的意见建议，组织开展分组调整临床论证工作。临床论证覆盖普通外科、妇科、产科、神经外科、神经内科、耳鼻喉科、眼科、

口腔科、胸外科、呼吸内科、甲乳外科、心血管内科、心脏大血管外科、新生儿科、骨科、泌尿外科、肾内科、感染疾病科、皮肤科、烧伤科、血液内科、肿瘤科、康复医学科、内分泌科、消化内科等 25 个专业。在亚组专家遴选上，重点选取与本次调整病种密切相关的亚专业专家，如普通外科涵盖胃肠外科、肝胆外科、甲乳外科、肛肠外科、疝与腹壁外科等亚专业，确保论证意见更具针对性和专业性。重点对先期分组、手术操作和诊断“并项”规则、相关诊断辅助细分组等涉及分组规则调整的内容进行论证分析。

各地按照 **DIP** 病种动态调整流程，以 3.0 版国家病种库为基础，结合本地实际，按进度要求调整更新本地病种库。

第四章 按病种付费总额

第一节 编制原则

一、内涵

按病种付费总额是统筹区医保基金总额的组成部分。是统筹区根据上年度按病种付费总额，结合当地经济社会情况、医保基金运行、医疗费用变化等因素测定的用于按病种付费的基金额度。用于测定 DIP 年初点值，也是执行中调整和结算清算的基准。在测定结算点值时，要根据本年基金收入决算数合理调整按病种付费总额，一般情况下，应与筹资增长相适应。

二、实施要求和原则

（一）保障基本

坚持“以收定支、收支平衡、略有结余”，保障参保人员基本医疗需求，促进医疗卫生资源合理利用，提升基本医疗保险基金使用效益。

（二）科学合理

以基本医疗保险基金预算及历史运行规律为基础，充分考虑当地经济社会发展水平、医保基金运行情况、人民健康需求等因素，科学测算，合理确定。

（三）激励约束

该额度可用于核定年度住院总费用，用于落实激励约束机制，促进定点医疗机构规范诊疗行为、合理控制成本、提高服务质量与效率。

第二节 总额确定

一、总额确定流程

统筹地区需明确本年度基金预算总额，区分职保、居保，包括异地就医预算总额。确定病种付费总额的具体步骤包括：

（一）测定统筹区支出预算总额

一般包括住院医保基金支出预算、普通门诊统筹基金支出预算、特殊疾病门诊统筹基金支出预算、风险备用金等，按一定比价关系，统一实施区域点数法预算管理。

（二）测定统筹区住院支出预算总额

主要包括住院医保基金支付预算，对 **DIP** 以及床日付费、中医优势病种、医共体按人头等多元复合支付方式，可通过统一点数口径实现不同支付方式之间的衔接。

（三）测定 **DIP** 付费总额

进一步细化形成针对 **DIP** 住院统筹基金支付的基金总额。

二、总额测定方法

在总额确定过程中，一般可采用按支出项目分配、按比例分配、按增长率测算三种方法：

（一）按支出项目分配法

以年度住院医保基金支出预算为基础，扣除区域调节金、异地就医，以及其他不纳入 **DIP** 结算的费用等，确定年度 **DIP** 医保基金支出总额（即 **DIP** 住院统筹基金可支付总额）。

（二）按比例分配法

根据上年度 DIP 住院统筹基金支付总额占上年度住院统筹基金支出总额的比例，在当年住院统筹基金总额中，计算出可用于 DIP 结算的基金总额。

（三）按增长率测算法

采用上年度 DIP 住院统筹基金支付总额，在此基础上考虑一定增长率，确定当年 DIP 付费总额。增长率的设置，一般需综合考虑经济增长、人口结构、医保筹资等，以及历年参保人数、定点医疗机构服务的病种结构及数量、医保结算费用、医疗服务价格水平等因素等。增长率一般不高于统筹地区医疗费用增长率控制目标或公立医院医疗费用增长幅度。

第三节 分配与执行

一、总额分配

在年度总额框架内，可实行以下分配方式：

（一）浮动点值法管理

在年度总额框架内，将定点医疗机构提供的药品和医疗服务项目等付费单元，按照比价关系折算为点数，并以各医疗机构提供医药服务的总点数作为医保统筹基金分配的依据。一般可采用浮动点值法，年初结合上一年度点值水平等因素确定预算年初点值；当年实际运行总费用及总点数，年终清算时确定清算点值。

（二）弹性点值法管理

在年度总额框架内，可根据管理需要，实行弹性点值法按病种付费总额管理模式，按照服务量、病种性质、成本结构等类别，对

总额实行分类管理，区分基准总额与增量总额，分别对应固定点值与浮动点值（统称弹性点值），以达到引导医疗机构“保障基本、稳定预期，适度竞争、合理发展”的管理目标，主要形式包括：

1.基准服务量固定与增量服务量浮动

基准部分以上一年度医疗机构合理服务量为基础折算确定基准服务点数，对应提前预设好的固定点值形成基准总额，基准部分实施固定点值核算。增量部分为当年度超过合理服务量形成的增量服务点数差额，按照浮动点值进行核算；浮动点值由区域增量预算总额（区域总额与基准总额的差值部分，包括按实支付部分）与对应增量服务点数测算形成，并可设置合理上限，控制点值过度波动。基准总额与增量总额比例一般以 8:2 或 7:3 为宜。

2.重症病种固定与轻症病种浮动

根据疾病临床诊疗特点，对医疗技术难度较高、疾病发展严重的病种，实行重症病种对应固定基准总额，实施预设好的固定点值核算；对常见病、慢性病稳定期等轻症病例，实行轻症浮动增量总额，参照全区域最终核算的浮动点值核算。

3.刚性成本固定与弹性成本浮动

结合医疗服务成本结构，对药品、医用耗材等刚性支出，依据历史数据核定各病种基准成本，实行病种成本固定基准总额，实施预设好的固定点值核算；对检查、检验及诊疗服务等弹性较大的项目，由扣除固定成本后的增量总额与相应服务点数测算形成浮动点值管理。

二、动态管理

医保统筹区应当加强按病种付费总额与医疗机构实际发生的待

结算之间的监测分析，重点关注总额使用进度、点值结算及变动、结余或超支等情况，及时分析执行偏差及其原因，根据实际需要适时启动调整程序。总额调整要注意额度适宜、程序规范。

第五章 核心要素

病种分值、点值和调整系数，是按病种付费核心要素的重要组成部分。各地应按照国家统一要求，完善分值、点值和调整系数管理及动态调整机制，推动病种付费标准更加科学体现医疗资源消耗，提高医保基金使用效能。

第一节 分值及计算

病种分值以当地历史住院费用为基础，通过该病种组合中所有病例与本地全部病例的平均住院费用的比值确定。各地可根据资源消耗结构、疾病诊治难易程度、医保政策目标、临床学科发展等，通过专家论证、谈判协商等适当调整病种分值。分值调整时，原则上保持总分值不变，以病种为单位进行内部结构调整。逐步探索省内病种分值统一，引导医疗资源合理配置。

分值反映不同病种的医疗资源消耗相对于平均医疗资源消耗的程度。标准分值通常采用该病种的次均医疗费用与统筹地区次均住院医疗费用的比值表示，也可采用基准病种费用法或标准定额法计算。分值越高，代表该病种消耗的医疗资源越多。总分值为各病种分值与住院患者例数乘积之和。可在总分值不变的原则下，根据地方实践经验和历史数据、协商谈判结果、优化医疗资源消耗结构等因素，对不同病种标准分值进行调整优化，形成付费分值。分值调整应统筹考虑本地和异地住院医疗费用情况。

病种分值的计算是通过当地全口径（包括医保患者及自费病人）

的历史费用数据计算，对不同出院病例进行标化的过程。分值可体现医院医疗服务产出的差别，是确定 DIP 支付标准的基础。分值计算可采用平均费用法、基准病种费用法或标准定额法。各地可根据实际需要选择其中一种方法。

一、平均费用法

- 1.计算每个病种组合的平均住院医疗费用 m_i ;
- 2.计算本地所有出院病例的平均住院医疗费用 M ;
- 3.计算病种分值 RW_i ，计算公式为： $RW_i = m_i / M \times 1000$ 。

二、基准病种费用法

- 1.计算每个病种组合的平均住院医疗费用 m_i ;
- 2.选择本地普遍开展、临床路径明确、并发症与合并症少、诊疗技术成熟且费用相对稳定的某一病种（例如“急性阑尾炎：腹腔镜下阑尾切除术”）作为基准病种，测算基准病种的平均住院医疗费用 M ;
- 3.计算病种分值 RW_i ，计算公式为： $RW_i = m_i / M \times 1000$ 。

三、标准定额法

- 1.计算每个病种组合的平均住院医疗费用 m_i ;
- 2.设定标准定额，例如设固定参数 M 相当于分值为 1;
- 3.计算病种分值 RW_i ，计算公式为： $RW_i = m_i / M$ 。

以上三种方法中，平均住院医疗费用均以近三年的历史数据按照时间加权的形式计算，综合反映历年疾病及费用的发展趋势。如当前年度为 2023 年，则采用前三年历史数据，按照 2020 年:2021 年:2022 年=1:2:7 的比例进行测算。

无论采用何种计算办法，都需要注意病种分值的合理性、延续性和病种之间的相对性。对通过规范诊疗、合理管控成本带来历史平均（项目）费用下降的病种，不能盲目降低该病种分值。

四、分值结构

病种分值的计算方法，可快速推广至细分的医药费用结构，形成针对单个病种中药品及耗材的标化单位，对资源消耗进行监测分析、结构评价，具体包括药品分值和耗材分值，主要用于开展病种层面的医疗服务行为纵向和横向比较分析。

（一）药品分值

DIP 药品分值（dRW）依据全样本数据病例平均药品费用测算，是反映不同病种组合中药品消耗程度的相对值，数值越高，反映该病种的药品消耗越高，反之则越低，计算公式为：

$$dRW_i = dm_i / dM$$

dM: 全部住院病例平均药品费用。

dm_i: 第 i 类病种组合内病例的平均药品费用，可用 3 年往期数据的加权平均数反映历年疾病及费用的发展趋势。

（二）耗材分值

DIP 耗材分值（cRW）依据全样本数据病例平均耗材费用测算，是反映不同病种组合中耗材消耗程度的相对值，数值越高，反映该病种的耗材消耗越高，反之则越低，计算公式为：

$$cRW_i = cm_i / cM$$

cM: 全部住院病例平均耗材费用。

cm_i: 第 i 类 DIP 内病例的平均耗材费用，可用 3 年往期数据的加权平均数反映历年疾病及费用的发展趋势。

（三）新药新技术分值加成

可逐步探索应用卫生技术评估（HTA）方法，对新药新技术的临床价值、创新价值、经济价值、社会价值等进行综合评估，对临床必需且对病种分值有较大影响的新药新技术等项目，经专家论证及数据验证后，可对相应费用单独计算加成分值，体现价值付费导向。

结合地方实际，分值加成项目可包含以下类型：

- 1.协议期内国家医保谈判药品。
- 2.应用于同一住院过程的联合手术、联合治疗且暂无相应 DIP 病种的医疗技术。
- 3.临床必需且对 DIP 病种分值有较大影响的其他项目。

五、大数据应用

在分值计算和调整中，还需综合考虑更大样本数据和标准数据（即临床路径下的资源消耗），进行纵向和横向比较分析和校正，结合临床路径，形成部分病种的分值校正机制。鼓励医疗机构规范病种临床路径，促进临床规范。

第二节 调节系数

临床实际治疗过程中，同种疾病在不同类型定点医疗机构治疗，或受到不确定性因素影响，其医疗资源消耗存在一定差异。同时，为了综合运用定点医疗机构的日常考核、协议管理等结果，可设置医疗机构调节系数、辅助分型调节系数等，用于病种分值调整。

一、医疗机构调节系数

统筹地区可根据定点医疗机构级别、功能定位、医疗水平、专

科特色、病组结构等因素，合理设置系数，促进因病施治，推进分级诊疗。通过设置医疗机构调节系数，体现各类型定点医疗机构之间治疗同种疾病所需次均住院费用的客观差异。也可采用按综合医院等级、专科医院系数、部分病种系数或多因素叠加等方法设置。

（一）以医疗机构设置

1.按医疗机构分类设定系数

即综合考虑各定点医疗机构级别（如一、二、三等级）、类型（如综合、专科）、医疗费用的客观差异，以及医保部门对医疗机构绩效考核情况等综合因素，将医疗机构分为不同等级和类型，计算医疗机构系数。

计算公式为：

医疗机构调节系数=同级别类型医疗机构近三年数据病例加权平均住院费用/全市近三年数据病例加权平均住院费用

其中专科医院调节系数可根据各地专科医院诊疗实际给予单独加成设置。

2.探索综合因素调节系数

对于管理具备一定基础，并随着改革的持续推进，调节系数应逐步精细化。可视不同医疗机构在参保人病情、提供医疗服务过程中所消耗的医疗资源、重点专科建设特色等方面存在的差异性，采用基本系数与加成系数相结合的方法。

其中，基本系数主要区分医疗机构等级类型与功能定位；加成系数综合考虑医疗机构的医疗水平、专科特色（如重点学科）、病种结构（如 CMI）、绩效考核、协议履行情况等因素。

通过对多维管理指标进行加权计算，确定医疗机构系数，以引

导医疗机构回归功能定位，从“多劳多得”向“优劳优得”转变；保障特殊人群的就医需求。

计算公式为：

医疗机构调节系数=基本系数+加成系数

（二）以病种设置

在以医疗机构设定医疗机构调节系数的基础上，可遴选部分病种，以病种为单元对各级各类医疗机构设定不同的调节系数，体现该病种在不同等级类型医疗机构的诊疗特点和资源消耗差异，以利于实现精准支付。

计算公式为：

医疗机构等级调节系数=同级别类型医疗机构某病种近三年数据病例加权平均住院费用/全市该病种近三年数据病例加权平均住院费用

遴选病种时建议按照以下原则：

- （1）该病种在不同等级类型医疗机构资源消耗差异大。
- （2）该病种覆盖历史病例数较多，且各等级类型医疗机构病例数不低于一定阈值。
- （3）各等级类型医疗机构次均费用不倒挂。

其中，对于保守治疗的病种，建议仅以医疗机构类别设定系数，而不再以病种计算系数。对基层病种不区分医疗机构调节系数，实施同病同治同价。

二、辅助分型调节系数

疾病的不确定性是医疗服务市场的特点之一。通常情况下，受不确定性因素影响的个案对大数据结果影响较小，但随着其病例数量的增加，会对医疗机构的费用造成一定影响。除了在分组规则中，

基于国家病种库中基于相关诊断辅助细分的核心病种之外，其他情形需要基于大数据寻找规律，对病种分值进行特殊处理，赋予辅助系数提高病种分值。

主要包括：CCI 分型、疾病严重程度、年龄特征、重症监护等特异变化。通过设置一定的触发条件，选出需要应用辅助分型的病种，针对病种内导致费用存在明显差异的主要影响因素，选择适宜的辅助分型应用类型，对受影响的病种进行细化分型，测算辅助分型调节系数，以最大程度地契合成本，对病种分值进行校正。

（一）辅助分型应用的触发条件

对于核心病种，应用辅助分型时，应遵循必要、客观、尊重临床实际的原则，进行辅助分型的病种不宜过多、过细，需结合实际数据情况，建议满足以下触发条件：

1.该病种上年度病例数超过一定例数例（具体数值由统筹地区医保部门结合当地实际情况设定）；

2.其中参与某一分型评估的病例数超过一定例数（具体数值由统筹地区医保部门结合当地实际情况设定）；

3.采用辅助分型分组后费用差异明显改善。例如某一病种的组内费用变异系数偏大，使用辅助分型后，某一病种各分型间的费用变异系数较小，且下降明显（例如 20%以上）。

其中，监护病房住院天数辅助分型的触发条件可以适当放宽，中医优势病种、床日病种病例不纳入辅助分型范围。

（二）确定各分型的触发系数

计算公式：某一病种的辅助分型触发系数=该辅助分型上年度病例平均住院费用÷该病种上年度平均住院费用。

当病例符合多个辅助分型规则时，纳入该病种辅助分型触发系数最高的分型中计算调节系数。

（三）辅助分型调节系数的确定

某一病种的辅助分型调节系数= m_j/M

其中：

m_j ：该病种内第 j 类辅助分型上年度满足触发条件病例的平均住院费用；

M ：该病种上年度全部病例平均住院费用。

（四）辅助分型的类型

针对恶性肿瘤、非恶性肿瘤等疾病，根据病情轻重、治疗费用等因素进行分型，分为恶性肿瘤疾病严重程度辅助分型、非恶性肿瘤疾病严重程度辅助分型。并按照疾病严重程度进行分级，客观反映疾病的复杂程度以及资源的消耗水平，进一步降低组合变异系数（CV），更好地契合成本。具体包括：

一是恶性肿瘤疾病严重程度辅助分型。具体分型规则如下：

（1）死亡病例；

（2）高费用病例类型一，例如医疗费用不小于该病种分值费用标准 3 倍，治疗费（不含手术费）占比不小于 50%；

（3）高费用病例类型二，医疗费用不小于该病种分值费用标准 3 倍），药品费用占比不小于 50%；

（4）肿瘤有转移或其他部位并发的病例，次要诊断中含有恶性肿瘤的诊断且所属类目与主要诊断不同，住院天数 3 天以上；

（5）次要诊断属于“功能衰竭、休克、脓毒症”范围，且住院天

数 3 天以上的病例；

（6）次要诊断属于“重要器官病损、重要脏器感染”范围，且住院天数 3 天以上的病例；

（7）其他情况。

二是非恶性肿瘤疾病严重程度辅助分型。具体分型规则如下：

（1）死亡病例；

（2）重度：次要诊断属于“功能衰竭、休克、脓毒症”范围，且住院天数 3 天以上的病例；

（3）中度：次要诊断属于“重要器官病损、重要脏器感染”范围，且住院天数 3 天以上的病例；

（4）轻度：其他病例。

2. 年龄特征分型

利用疾病与年龄之间的关系建立年龄特征辅助分型，重点针对 18 岁以下及 65 岁以上的病种进行筛查，对个体差异、疾病严重程度等原因进行分析以确立合适的校正权重，实现基于数据特征的医保支付调节，引导医院针对患者的病情采取合理的治疗方案，从而避免推诿危重病人。

（1）18 岁以下病例

大数据分析显示，儿科疾病资源消耗往往与年龄阶段有较高的关联度，按照新生儿期、婴幼儿期、学龄前期、学龄期、青春期等不同阶段的划分，对每阶段的特征病例进行识别，结合医疗资源消耗给定加权系数，客观拟合儿科疾病的成本消耗。例如 0-28 天、29 天-1 周岁、1-6 岁、7-17 岁。

（2）65 岁以上病例

老年疾病往往伴随并发症/合并症，且疾病严重程度差异性大，利用疾病严重程度辅助分型进行校正，对不同年龄段、不同严重程度的病例进行识别，结合医疗资源消耗给定加权系数，客观拟合老年疾病的成本消耗。

表 5-1 年龄特征病种辅助分型应用示例

	诊断编码	诊断名称	操作编码	操作名称	平均住院费用	病种分值	年龄特征病种				
							0-28天	29天-1周岁	1-6岁	7-17岁	65岁以上
病种1	C91.0	急性淋巴细胞白血病[ALL]	.	保守治疗	34346	2593	—	—	系数: 0.79 均费: 27133	系数: 1.8562 均费: 63753	系数: 0.6012 均费: 20649
病种2	D18.0	血管瘤, 任何部位	.	保守治疗	5547	419	—	系数: 0.499 均费: 2768	系数: 0.9957 均费: 5523	系数: 1.1984 均费: 6647	系数: 1.2685 均费: 7036
.....											

3. 监护病房住院天数分型

监护病房是指层流洁净病房、层流洁净简易病房和监护病房。对纳入监护病房的病例按监护病房住院天数进行分型，例如 2-7 天、8-14 天、15-30 天、31 天及以上等。

第三节 当年病例分值

一、确定病例分值

DIP 结算时，根据当年病例入组情况，按照各医疗机构当年入组病例数、各病种分值及分值调节系数（如医疗机构等级系数、辅助分型调节系数等），计算相应分值。计算公式为：

病例分值=该病例所属病种分值×医疗机构调节系数

其中，对于当年度纳入辅助分型调节的病例，应用辅助分型调节系数计算相应分值。计算公式为：

辅助分型病例分值=该病例所属病种分值×医疗机构调节系数×
辅助分型调节系数

对存在费用异常、特殊情况相应情形的病例，可对病例的分值
进行调校。同时，建议控制进行分值调校的病例数占比。

二、费用异常病例分值调整

通过疾病严重程度辅助分型进行个体特异变化校正后，仍会有
部分费用异常病例，需要建立基于大数据的费用异常病例筛选机制，
确定合理的系数并对分值进行调整，具体如下：

1.费用超低病例

一般将费用低于同级别定点医疗机构 DIP 病种支付标准 50%的
病例作为费用超低病例：

费用超低病例分值=该病例所属病种分值×分值调节系数×费用
超低病例分值校正系数

其中：费用超低病例分值校正系数=该病例医疗总费用/（该病
种的支付标准×分值调节系数）

2.费用超高病例

一般将费用为同级别定点医疗机构 DIP 病种支付标准 2-3 倍
（含）的病例作为费用超高病例。为了兼顾临床复杂性和支付调控
的有效性，既要承认一定比例超高病种存在的合理性，也要防范医
疗机构由于非合理原因发生大量的超高病例。合理的费用超高病例
原则上可以纳入特例单议。

第四节 年初点值计算及应用

DIP 点值确定的原则是保证医保基金收支平衡，提高医保基金使用效率，促进区域卫生资源合理配置。根据数据来源和适用场景可分为年初点值和结算点值。

一、定义

DIP 年初点值在每年年初测定，它是促进定点医疗机构落实医保过程控制的重要指标。

二、计算方法

基于历史（通常为三年）住院费用，同时考虑区域服务人口、疾病谱以及医保基金变化情况，计算年初点值，作为总额编制的基础、过程控制的标准以及预付预扣的参考。

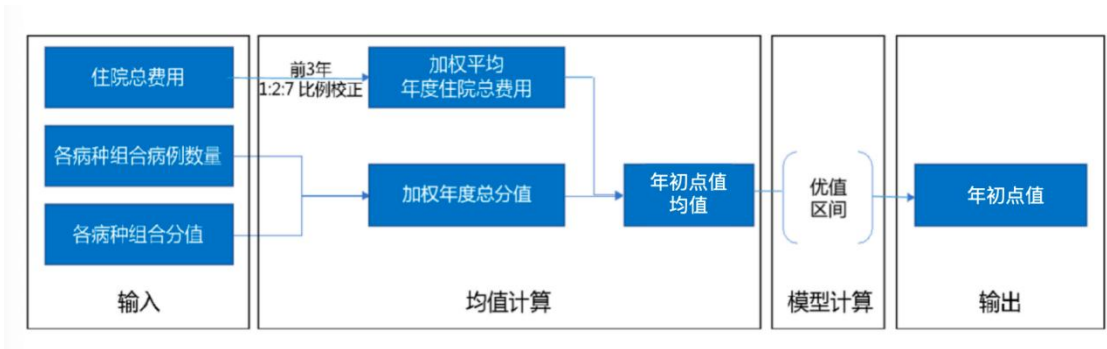


图 5-1 DIP 年初点值测算流程

计算公式为：

年初点值的地区均值=加权平均年度住院总费用/加权年度总分值

其中，年度住院总费用采用加权平均的方式计算，与 DIP 分值的计算过程相似，前 3 年住院总费用的权重为 1:2:7。

可采用分位数法或优值区间的方法，减少医疗机构往期历史数据中不合理费用的影响，具体如下：

（1）分位数法

采用分位数法，例如设置 97.5%和 2.5%为裁剪上下限，根据历史病例数据的住院费用进行裁剪。

（2）优值区间

可利用一维或二维角度形成对资源过度利用的校正，减少往期病例数据中过度服务导致的不合理费用影响，形成 DIP 的对标标准，实现对各医疗机构收入或资源消耗（实际成本）的客观评价。

一维角度以低于每指数点值地区均值的区段作为优值区间，利用该区间的加权平均值作为年初点值。

二维角度根据各医疗机构标化后的收入与成本建立比较关系，以每指数点值和每指数成本的地区均值为坐标系，以每指数点值低、每指数成本低，即收入低、成本低，且收入能覆盖成本的医疗机构集中的区域作为优值区间，利用该区域的几何中心（距离象限区域中所有的点的距离之和最小的点）作为年初点值，可最大限度反映各医疗机构收入相对于成本的实际情况。

其中，地区及各医疗机构的收入与成本标化方式如下：

每指数点值=住院总费用/病种总分值

每指数成本=住院总成本/病种总分值

DIP 支付标准，既考虑了医疗服务的收入，又考虑了医疗服务的成本，以几何中心凸显客观、随机均值及优选区间，其核心是追

求支付标准与医疗服务合理成本的最大契合，体现医保支付导向。

第五节 结算点值计算及应用

一、定义

DIP 结算点值在每年年度清算时确定，以按病种付费总额为前提，按全年实际发生的 DIP 总分值计算形成，用于确定支付标准、与定点医疗机构进行年度结算、清算。

二、计算方法

DIP 结算点值基于当年医保支付总额与医保支付比例核定可覆盖的年度住院总费用，并结合年度 DIP 总分值，计算结算阶段的分值点值，形成 DIP 支付标准。

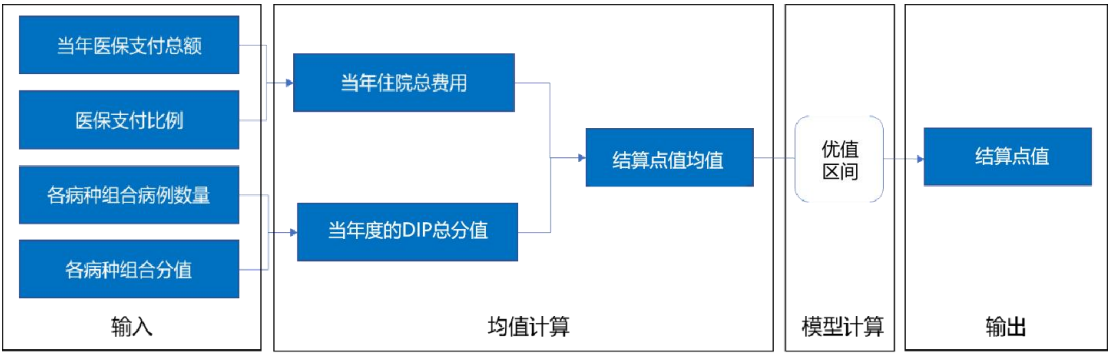


图 5-2 DIP 结算点值测算流程

计算公式为：

结算点值的地区均值=（当年医保基金可用于 DIP 付费总额/医

保支付比例) /当年度的 **DIP** 总分值

与年初点值相同，基于结算阶段的点值均值，采用分位数法或
优值区间模型的方式计算结算点值。

第六章 支付标准

第一节 计算方法

一、定义

一般的病种支付标准为相应病种分值、点值的乘积。其中，通过年度医保可支付基金额、医保支付比例及 DIP 病例总分值计算出点值，再乘以每一个病种的分值形成支付标准，依据医保支付范围以及不同人群的医保待遇政策，通过月度预付（或结算）、年度结算清算等步骤兑现医保基金支付。

二、计算公式

DIP 病种基础平均支付标准为病种分值与年度统一点值的乘积，是常规病例医保支付的基准依据，具体公式如下：

DIP 病种平均支付标准=DIP 病种分值×点值

三、影响因素

DIP 病种支付标准变动受以下多因素影响：

（一）医疗技术变化因素：医疗技术的迭代升级、临床诊疗方案的优化革新，将改变原有病种的诊疗流程、资源投入与成本结构、影响病种医疗资源消耗。

1. 新技术、新项目的临床应用，能够有效缩短住院周期、降低并发症发生率、提升诊疗效率，减少基础医疗资源消耗，推动病种诊疗成本整体下降。

2. 部分新型诊疗技术、高端精准治疗手段，存在设备投入高、耗材成本高、技术门槛高的特点，会显著提升单病例诊疗成本与诊疗难度，原有病种分值无法适配新的诊疗模式。

3. 临床诊疗路径的规范化优化、适宜技术的普及应用，会推动同病种诊疗同质化、标准化，为 **DIP** 支付标准精准核定提供标准化临床基础。

（二）疾病谱变化因素：人口老龄化、居民生活方式改变、生态环境变化、传染病流行特征迭代等因素会导致区域疾病谱的动态变迁，直接改变 **DIP** 病例结构与整体基金分值总量。

1. 慢性病、老年病、复合型疾病发病占比逐年提升，该部分病例普遍存在基础疾病多、诊疗周期长、复发率高的特点，会拉高病种诊疗成本与区域整体分值规模。

2. 季节性疾病、突发流行性疾病的阶段性高发，会在短期内直接改变本地区病例结构，影响地方病种目录的使用。

（三）医保政策影响因素：医保政策调整将直接影响病种支付标准，同时联动各类医保配套政策形成系统性影响。例如价格项目立项、药品耗材集中带量采购、医保目录准入退出等会直接改变对应病种的诊疗费用构成与成本基准，倒逼对应 **DIP** 病种分值及支付标准同步校准。

四、调整方式

为了适应临床病例的复杂性和差异化，统筹区可综合考虑以上影响因素，对因素可能带来较大影响的病种支付标准进行具体测定；对部分病例再行配套特例单议、谈判协商等机制，对其支付标准进

行必要的调整，而不是全部病例一概采用统一的平均支付标准，以实现付费的科学化、合理化、精准化。

第二节 特例单议机制

一、适用范围与数量限制

医保部门建立特例单议机制，规范特例单议标准、申报程序、审核流程、结算办法等，结合国家支持创新药和医疗器械发展有关政策要求，支持医疗机构收治复杂重症患者、合理使用新药耗新技术。

申报特例单议的病例包括住院时间长、医疗费用高、新药耗新技术使用、复杂危重症或多学科联合诊疗等，不适合应用病种平均支付标准的病例。特别要关注儿科（含新生儿）、多脏器损伤、烧伤、传染性疾病等相关病种、特殊病例的合理支付。

特例单议病例数量原则上不超过统筹地区 DIP 出院总病例的 5‰。在实施过程中，要合理分配 5‰的病例数，不能以每家医疗机构的病例数为基数计算 5‰的数量。应充分考量一个病种在不同医疗机构分布情况，尤其是疑难重症收治情况。各定点医疗机构可以对照各病种平均支付标准，对超过平均支付标准 2 倍以上的病例，纳入申报范围。

二、申报与评审

医疗机构可根据申报条件，自主申报特例单议病例。医保部门应畅通特例单议受理渠道，完善工作制度，优化工作流程，简化上报材料，提升评审效率，可同步开展线上、线下受理及评审，改善

申报体验。

统筹地区医保经办机构负责组织特例单议病例评审，一般按月或季度开展。评审可采取智能评审和专家评审相结合的方式，也可探索线上线下评审、医疗机构交叉评审等方式进行。医保部门根据评审意见，作出特例单议评审通过或不予通过的结果判定，并及时告知申请医疗机构。有条件的地方可缩短评审周期，提高工作效率。

三、结算处理与信息公开

对评审通过的病例，可按项目付费或调整该病例支付标准等方式予以合理支付。对评审不通过的病例，仍按病种规定付费。

统筹地区医保经办机构定期向医疗机构或社会公开特例单议申报及评审情况，接受监督。公开的内容主要包括各医疗机构申报特例单议的数量、审核通过数量、占按病种出院病例比例、医保基金支付、占医保基金支出比例等情况。特例单议结果纳入当年按病种付费清算。

第三节 谈判协商机制

一、内涵

统筹地区医保部门应建立关于按病种付费总额、分值、点值、调节系数等支付核心要素的谈判协商机制，以客观费用、基金支出为基础，协商谈判代表可由定点医疗机构代表、行业（学）协会、卫生健康和医保等部门共同参与，也可探索邀请参保人代表参与谈判协商。谈判协商是营造多方参与的改革协同机制，是促进医保部门和医疗机构良性互动的重要保障及工作机制。

二、协商原则

谈判协商遵循“公平公正、客观合理、多方参与、及时处理”的原则。从切实维护人民群众实际利益出发，充分考虑医保基金运行状况和医疗机构高质量发展的实际需要，建立在事实和客观支撑基础之上，从而有效落实法律法规和相关政策规定，实事求是、客观实际、凝聚共识。

三、协商主体

谈判协商工作由统筹地区医保行政部门、经办机构组织，医疗机构、技术专家参加。邀请医疗机构参与时，要统筹考虑不同类型、不同级别的医疗机构，协商代表不仅包括医院管理层、临床专家，还可根据协商具体事项邀请涉及具体业务的编码、病案、药械、信息等相关科室人员。视工作情况可邀请医保支付方式改革专家组、技术指导组中具有丰富经验的专家参与指导谈判协商，及时解决谈判工作中遇到的政策性和技术性问题。

四、协商内容

谈判协商内容可以涵盖年度协议续签、按病种付费办法修订、病种目录确定、按病种付费总额、分值点值、调节系数、医疗保障基金使用绩效综合评价等支付核心要素、配套机制政策等工作。根据不同的事项，分别确定单次集体谈判协商内容。

第七章 结算清算

统筹地区医保经办机构要按照协议规定，严格做好基金预付、结算、清算等工作，及时结算和拨付医疗保障基金。对医疗机构申报的相关费用，严格按规定审核、核查，确保基金使用规范。

医保基金清算改革是一项系统工程。各地应把“解决问题”的功夫下在平时，强化日常工作，夯实清算基础，减少年度集中处理压力，不断提升清算质量和效率。在高质量完成医保基金结算的基础上，推进清算提速，自 2028 年起，实现每年 3 月底前完成上年度清算，清算资金占年度医保基金拨付的 3% 左右，推进季度清算等创新模式。鼓励有条件的地方，探索将大病保险资金和医疗救助基金等纳入清算提速范围，逐步缩短异地就医费用清算周期。

第一节 日常审核

一、定义

日常审核是指医保经办机构依据协议约定和相关规定，对定点医疗机构按病种付费申报数据和相关费用开展常态化审核、核查的管理过程，是基金预付、月度结算和年度清算的基础环节。按病种付费清算是清算的重点和难点。省级医保部门要指导统筹地区，将按病种付费相关工作分解到平时，注重日常的沟通协商和争议处理，及时解决问题，减少矛盾积压。各地要解放思想，突破瓶颈，借助信息化，推进“马上办”“自动办”“掌上办”，化整为零，减少问题积压，化解年度集中处理业务的压力。

二、主要内容

定点医疗机构在月度对账完成后，在规定申报期限内（通常是下个月月上旬）向医保经办机构申报应由医保基金支付的费用。收到定点医疗机构申报后，经办机构应对申报费用开展审核，并在审核后予以支付。经办机构建立初审、复审等业务流程，原则上采取全面审核的方式对参保人发生的医保费用进行审核，对“明确违规”费用直接拒付。审核应实现本地和异地、门诊和住院医疗费用全覆盖。

第二节 基金结算

医保部门与定点医疗机构按照“年初预拨、月度预付、年度清算”的方式进行医疗费用结算。各地需明确 DIP 政策下医保和医疗机构的费用结算细则，使结算工作有据可依，有章可循。同时，加强费用结算流程的规范化管理，提高费用结算的时效性和准确性，促进医保、医疗、医药协同。

在实际付费后，如果统筹区的 DIP 结算基金与医疗机构记账资金差异过大的，需要研究结算细则的科学性、合理性，并适时完善，以保障 DIP 支付方式改革的平稳推进。

各地要推动月度按病种实际结算，并落实基金结算改革要求，推进医保与定点医药机构即时结算，采取多种措施缩短结算周期，减轻医药机构资金周转压力。

一、预付金

各地应按规定做好基金预付，结合实际进一步完善预付金管理，根据统筹地区医保统筹基金累计结余和医保基金运行风险等级等因

素，确定是否进行预付以及预付规模等，预付规模应在 1 个月左右。规范预付金管理流程，做好对账核算工作，会同财政部门强化监督。

对上年度履约情况良好的定点医疗机构，可在年初按照一定比例设置周转金并预付给该定点医疗机构，以保证其正常财务运行。具体比例由各地根据实际情况确定。

二、月度预付

各地要推动月度按病种实际结算，并落实基金结算改革要求，推进医保与定点医药机构即时结算，采取多种措施缩短结算周期，减轻医药机构资金周转压力。

（一）计算月度应预拨的医保基金

月度预付时，应聚焦于计算应预拨的医保基金（建议根据 DIP 应支付的医保基金金额，按照一定比例进行月预拨付），与定点医疗机构核对后，完成月度应付款项的拨付。

在费用审核工作中的审核扣减费用，在月度结算拨付时同步扣减。

（二）反馈月度运行情况

月度预付中，应加强 DIP 运行情况的反馈。根据地方实际，可定期（按每半年、每季度或每月）或不定期向医疗机构反馈病种成组结果、按年初点值测算的可结算基金，以及医保结算清单上传率、入组率、质控通过率等信息。

在年度总额管理基础上，按照历史费用的发生规律去分配每个月的额度，医保经办机构再按照定点医院当年月度额的 90% 进行拨付，剩下 10% 作为预留质量保证金。

医疗机构月度预结费用=（该医疗机构月度总权重×该月费率-该

月患者支付总额)×预拨比例-该月审核扣款

第三节 基金清算

根据按病种付费总额、核心要素核定结果、特例单议等支付机制运行结果、结余留用合理超支分担等方面，结合协议考核、考核评价、监测评估等结果，开展基金清算。按照规定时限向定点医疗机构拨付清算资金，并指导定点医疗机构对医保清算资金拨付情况进行确认，督促定点医疗机构按照财务会计制度等规定对应由其承担的医疗费用及时进行账务处理。通过落实数据公开、意见收集、特例单议、谈判协商等机制，减少年度清算压力，缩短清算周期。

清算结束后，应及时向定点医药机构反馈结果，做好沟通解读，充分听取意见建议，努力达成共识。清算结果应按程序审定，减少冗余环节，加快审核拨付程序；同时应提前与财政部门沟通，做好资金请款准备，促进资金及时拨付。按照《医保基金清算提质增效三年行动计划》要求，所有统筹地区应分阶段压缩清算时限，并自2028年起实现每年3月底前完成上年度清算。

医保部门根据清算结果，结合全年月度预付金额、预拨周转金、年度考核结果、审核扣款等，计算年度最终拨付医保基金，完成年度清算。

一、清算流程

各地应围绕清算提质增效要求，建立统筹协调、流程规范、系统支撑、信息公开等工作机制，规范推进年度清算。清算工作要重点抓好方案制定、数据准备、综合考核、金额核算、审定拨付等主

要环节。原则上年度清算应涵盖上述环节；按季度清算等一年多次清算的统筹地区，在确保全年清算各环节实施的基础上，可简化部分清算流程。

年度清算是对按病种付费年度运行情况进行综合核算和结果确认的过程。各地应规范清算流程，提升清算效率，加强与绩效考核、数据发布等工作的衔接，确保清算结果客观、公平、可追溯。

清算前应制定清算方案，主要包括按病种付费总额、清算规则、清算流程、任务分工、完成时限等内容。清算前要对总额进行核定或按程序调整，确定可用于清算的资金额度。清算方案要充分论证、听取定点医药机构意见，确定后不得随意调整，原则上应向定点医药机构公开。

省级医保部门应规范全省医保基金清算流程，指导统筹地区按照“最小必须”原则精简优化流程，推进清算标准化、科学化、规范化。

（一）汇总清算信息

一是医保部门获取及核查定点医疗机构所上传的医保结算清单、费用数据等。二是汇总定点医疗机构清算年度综合考核得分、违规情况、分级管理评定情况等。三是完成费用异常病例等的筛查与评审。四是按规定汇总清算年度各定点医疗机构 **DIP** 的校正系数。

（二）计算年度病例总分值

按照规定的流程，计算出定点医疗机构的年度总分值。区域内年度总分值为每一家 **DIP** 医疗机构的年度分值累加。

计算公式为：

定点医疗机构年度分值=核心病种病例分值+综合病种病例分值

+中医优势病种病例分值+辅助分型病例分值+基层病种病例分值+特殊病例分值+新药新技术加成分值

（三）确定年度结算点值

根据年度 **DIP** 可分配资金总额确定结算点值。计算公式为：

结算点值=（当年医保基金可用于 **DIP** 付费总额/医保支付比例）
/当年度的 **DIP** 总分值

其中：医保支付比例是指定点医疗机构当年纳入 **DIP** 结算病例的实际记账金额与医疗总费用的比值。

（四）计算应支付的结算金额

确定定点医疗机构的年度考核结果，同时结合辅助目录对各医疗机构的异常费用进行识别与合理纠正，计算出医保基金按住院 **DIP** 应支付给定点医疗机构的总结算额。

计算公式为：

医保基金按住院 **DIP** 应支付给定点医疗机构的总结算额=〔 $\sum$ （参保人员住院所属 **DIP** 组的病例分值×结算点值×医保基金支付比例）〕×考核系数- $\sum$ 审核扣减费用

其中：考核系数根据地方实际考核工作开展情况设置。

二、基金清算

各地应结合按病种付费总额执行情况、医疗机构绩效考核结果和按病种付费运行情况，做实年度基金清算工作。上年度清算完成后，应及时做好数据发布，提高医疗机构对医保基金清算结果的知晓度。

清算金额核算要综合考虑基金运行、基金分配、点值和费率浮动等情况，结合医疗资源、医药费用等因素，将清算对医药机构的

影响均衡到全年，合理引导支付预期，稳步调节基金平衡。清算中要明确门诊与住院、本地与异地、多种支付方式等的清算额度分配，明确多种支付方式的清算规则，做好按病种付费、紧密型医共体付费等清算。

（一）结余留用，合理超支分担

实行“结余留用、合理超支分担”是发挥 DIP 付费方式经济杠杆的关键政策，是引导医疗机构主动适应按病种付费、规范诊疗行为、加强成本控制和提升精细化管理水平的关键机制。

从全国实践看，“结余留用”涉及三个层次。**区域结余**，是指在区域总额预算框架下，清算后区域内医疗机构实际发生统筹基金金额与区域总额之间的差额；**机构结余**，是指以医疗机构为单位，清算后医疗机构实际获得医保基金与其申报合规医保费用之间的差额；**病种结余**，是指医保按病种付费清算结果与医疗机构按项目记账之间的差额。三者之间是包含关系，其中病种结余是基础，机构结余是一定时期内各病种结余以及其他支付方式结余的汇总，区域结余则是各医疗机构合规医保费用与区域总额比较形成的结余。

是 DIP 撬动医疗机构主动管控资源消耗的核心。通过计算各定点医疗机构年度纳入 DIP 结算病例的费用明细审核扣减后的记账金额（即医疗机构与医保持结算款项），与该定点医疗机构年度 DIP 应支付的结算额（DIP 支付标准）之间形成的差额，判断“结余”（DIP 支付标准超过待结算款项）或“超支”（DIP 支付标准低于待结算款项）。

以医疗机构为单位来看，就是所有纳入 DIP 的病种，年度按病种付费结算金额与年度按项目发生金额之间的差额。结果为正数时，

表示为病种结余；结果为负数时，表示为病种超支。

“结余留用”是为了体现对医疗机构规范服务行为、主动控制成本的正向激励；“合理超支”是指非管理因素（如重大政策调整、突发重大流行疾病等）导致某病种诊疗成本总费用/次均费用超过医保核定的支付标准，或导致某个医疗机构出现整体超支的情况。

“合理超支分担”主要是为了体现基金使用管理中由于客观因素导致的风险共担要求。各地要建立健全“结余留用、合理超支分担”的激励约束机制，强化医保支付的科学合理性，提高医疗机构自我管理的积极性。地方可结合实际确定“结余留用”的具体办法。可以从按病种付费总额、按病种应支付金额、按项目付费记账金额、单个病例医疗费用与病组病种支付标准等方面，确定结余和超支的比例、分担比例、合理区间值等。做好实施前的数据模拟测算。

医疗机构通过规范服务行为、主动控制成本形成的病种结余资金，可按规定作为业务性收入。实施中应做好医保结余留用政策与集中带量采购等政策的衔接，形成政策合力。对超支分担事项，应结合按病种付费总额、结算清算和有关政策规定，稳妥实施。

（二）计算年度清算支付金额

以定点医疗机构年度纳入 **DIP** 结算病例的费用明细审核扣减后的记账金额，或医保基金按住院 **DIP** 应支付给定点医疗机构的年度总结算额为基数，进行“结余留用，合理超支分担”后，得到各医疗机构年度清算支付金额（年终预清算金额与全年月度预结算金额以及预拨周转金之差）。

（三）结果确认及费用拨付

一是将各医疗机构年度清算支付数据反馈给定点医疗机构核对，

收集处理定点医疗机构的反馈意见，并根据定点医疗机构反馈意见进行核查、处理，确定最终清算结果，及年度最终拨付金额。二是完成年度清算应付款项的数据汇总工作，汇总数据提交财务部门。三是完成年度清算应付款项的拨付。

第八章 运行监测

运行监测是按病种付费管理的重要组成部分。医保部门应加强对按病种付费管理运行成效的监测评估，从医保可持续、医疗增效能、群众得实惠等不同维度进行综合评价，客观全面反映改革成效，及时总结发现问题，为医保支付政策调整提供依据。国家层面应完善按病种付费可视化监测，推动实现病种结算结果可比较可分析。

第一节 工作实施

一、工作目的

医保部门从医保可持续、医疗增效能、群众得实惠等不同维度进行综合评价，客观全面反映改革成效，及时总结发现问题，为医保支付政策调整提供依据。

DIP 监测评价是医保部门对 **DIP** 运行过程进行监测衡量，对运行效果进行评价的过程。从制度建设、过程监测和效果评价三个维度，通过构建“国家-省-市”多层次监测机制，制定监测指标体系，为完善 **DIP** 管理、提高运行质量提供参考。

一是制度建设。从组织领导保障、工作机制完善、信息系统支撑、协同措施推进等方面评估制度建设情况。

二是过程监测。各改革地区需保证改革实施过程的规范性，从落实国家 **DIP** 经办管理规程、**DIP** 技术规范相关要求，规范推进按病种付费总额制定、数据采集应用、地方病种库编制、分值测算、调节系数设置、配套结算办法制定、监管考核办法制定等环节监测

实施过程。

三是评价改革效果。重点跟踪评价 DIP 改革地区医疗服务层面、基金监管层面、待遇保障层面的改革效果，是否充分利用考核评价成果建立激励约束机制，真正发挥医保支付“牛鼻子”作用。

二、监测流程与方式

（一）监测流程

1.明确 DIP 监测主体

国家-省-市的医保部门分别负责全国、本省及改革地区 DIP 支付方式改革的进展及运行监测分析，确定各项指标的监测方式、打分主体、得分标准，确保监测指标应用的客观性及可操作性。结合实际情况，也可委托专业机构对 DIP 改革情况进行科学客观分析。

2.开展相关数据收集

通过调取医保信息系统数据、查阅分析客观资料、对医疗机构及参保患者进行问卷、随访调查等多种方式，收集相关数据，主要包括：医保信息系统的就医、费用、支付、基金运行、参保患者负担等数据；医疗机构（住院）就诊分布和结构、业务收入、资源利用效率、医疗质量、运行状况等数据和资料；患者满意度调查等。

3.定期开展监测分析

评估方式采取定量分析和定性分析相结合的方式。各级医保部门要构建监测指标体系，并对 DIP 改革的实施进展及效果进行周期性评价分析。开展座谈访谈，听取定点医疗机构、参保患者各方关于 DIP 的意见、问题和建议。基于以上定量数据和定性资料判断分析，与基线调查情况进行前后对照。

4.完成监测分析报告

依托 DIP 的基线调查与推进过程中实际指标值的对比，分析费用变化及费用结构变化的合理性，研究行为变化的内在原因，探索指标变化的规律，把握医疗成本与医保支付费用之间的拟合程度，客观评价医保支付与监管工作的推进状况。监测分析报告应客观、全面和真实地反映 DIP 方式改革的整体效果，并对 DIP 运行中反映出来的问题进行系统梳理，分析原因，提出改进建议。

5.结果应用

针对实施过程中出现的问题，医保部门应与定点医疗机构建立集体谈判协商机制，按照“公平公正、客观合理、多方参与、及时处理”的原则，共同协商解决 DIP 中出现的争议和问题。

（二）监测方式

医保部门对 DIP 支付方式改革的监测主要包括日常监测和周期性评价。

1.日常监测。启动 DIP 付费后，监测医保住院的常规运行指标，并以病种为单位监测次均费用、费用结构等数据的变化。

2.周期性评价。在常规监测的基础上，可与结算、清算周期结合，对 DIP 改革的实施效果进行周期性评价，从病种管理角度，监测医保住院医药费用的整体情况、各医疗机构之间同一病种医疗行为的监测对比，结合日常监测分析指标进行周期性的医疗机构之间的监测分析。

第二节 监测指标

各省市需结合本地实际设置监测指标，依托信息化手段应用，

对 DIP 进行事前、事中、事后全流程监测。充分利用大数据分析方式，以区域、定点医疗机构为单位，加强对运行质量、改革效果相关指标进行监测分析，对 DIP 运行数据及时收集、统计分析、实时预警。

一、制度建设

从可持续发展角度，评估区域推进支付方式改革的组织领导是否明确、工作机制是否完善、信息管理系统是否健全、协同推进机制是否建立等方面，确保各地建立起保障支付方式改革的管理体系和运行机制。

二、运行质量

着眼“按病种付费总额”“病种成组”“分值”“点值”等关键技术实施规范与质量，建立一整套指标体系，量化评价改革实施过程，确保改革产生预期效果。

（一）按病种付费总额

监测评价总额准确度，即年度 DIP 医保基金额度与实际清算支付金额的比值；总额的年度间变化等。

（二）病种组合

监测核心病种占本地总病种数的比例；内科诊疗组核心病种与手术操作组核心病种数的比值；核心病种、综合病种覆盖历史病例数占比及整体入组率；应用辅助分型的核心病种数量；基层病种数量；中医优势病种数量；纳入临床路径管理的病种数量等。

（三）分值、点值

监测同一病种分值中，药品分值及其占总分值比例的变化，耗

材分值及其占总分值比例的变化；以及点值年度变异率、年初点值与结算点值差异率等。

（四）病种付费

监测当年度保守治疗与手术操作治疗病例占比；费用偏差病例占比；医保结算支付比，即统筹区域医疗机构总记账费用与年度清算确定实际支付总额之比，分析各级别、不同类型医疗机构间支付率情况；一、二级医疗机构基金支出占比增长率；以及次均费用增幅、次均药费增幅、次均耗材费用增幅等。

病种层面，监测各病种当年入组病例的均费、人次同比变化（降低率或增长率）；费用正常、直接入组匹配相应病种分值进行结算的病例数占比；费用超高病例占比、费用超低病例占比等。

（五）疾病和手术操作代码

监测数据上传率、准确率，以及疾病和手术操作代码质控通过率等。

（六）结余、超支情况

监测结余留用覆盖率，即获得医保基金结余留用的医疗机构占统筹地区定点医疗机构的比例。同时，分别监测分析结余和超支医疗机构数量、金额、结构等方面的变化及原因。

三、改革效果

（一）维护参保人合法权益

患者维度，分析实施 DIP 支付方式对患者的医疗费用负担、就医等待时间、医疗服务质量与安全等方面带来的影响。是否存在医院将费用转嫁给个人的情况；参保患者受益水平是否得到提高；评估 DIP 实施后参保患者对医疗行为和医疗质量的获得感是否提高等。

具体监测指标可包括：

自费比、自付比、短期入院率、平均住院天数、住院前一周内平均门诊检验检查费用、住院后一周内平均门诊医疗费用等。

（二）引导医疗服务合理发展

医院维度，建议各地医保部门与卫健部门协同监测，对机构层面和病种层面医疗服务行为进行纵向分析与横向比较，通过与历史情况的纵向对照，与不同医疗机构横向比较，评估改革前后医疗服务能力、医疗成本控制、医疗行为规范、资源使用效率、医疗服务质量、病种收治结构等方面的变化情况。

设置监测指标时，具体可包括以下两方面：

1.机构层面

一是院内运行指标。包括出院总病例数、入组病例数、入组率及同比变化，入组核心病种的病例数及占比；入组综合病种的病例数及占比、出院病例的医疗总费用绝对值及同比变化、纳入 DIP 结算病例的医疗总费用及占比、入组核心病种的病例医疗总费用及占比、入组综合病种的病例医疗总费用及占比；确定临床路径的病种数量及比例；医保统筹基金支付率（按 DIP 结算病例的基本医保基金支付金额与该部分病例医疗机构实际垫付金额之比）等。

二是实施效果指标。包括收治病例覆盖的 DIP 组数、住院服务量、病例组合指数（CMI）值及同比变化、实施手术治疗的患者占比、实施四级手术治疗的患者占比、医疗服务收入占比及同比变化、化验检查费用占比、组内差异系数（CV）小于 0.5 的病种数量、组内差异系数（CV）大于 1 的病种数量，一二三级医疗机构的住院人次占比变化情况。

三是医疗行为和医疗质量指标。包括住院分解率、低标入院、超长住院、死亡风险评估、出入院诊断符合率、30/14 天内同一疾病再入院率、院内感染发生率、平均住院日、门诊住院人次比、住院人头人次比、患者住院前或者住院期间到门诊缴费的指标等。

2.病种层面

监测同一病种的费用在不同医疗机构之间横向、同一家医院纵向对比及结构变化。分析 DIP 实施后，医疗机构是否主动优化费用结构，减少不合理用药和检查，使医药费用的不合理增长得到遏制，符合经济水平、医院定位及技术的发展趋势，有效保障参保人员权益。

具体监测指标可包括：

监测同诊断下病种的费用对比以及占比情况，如药品分值、耗材分值、门诊住院费用比例、实际支付比例和自费项目费用比例等水平及变化。同一病种同一家医院诊疗路径标准化，及药品、耗材使用标准化；同一病种同一区域内诊疗路径差异，及药品、耗材使用差异。

也可以基于病种目录分级管理思路做深度分析，建立监测指标。即将病种逐层向上聚合，形成一套包含主索引、一级目录、二级目录和三级目录的 DIP 目录分级体系。具体包括：

主索引依据主要诊断（ICD-10 医保版）各章的代码范围，对一级目录进行归类。可用以评估病种总体覆盖情况、医疗机构收治病种覆盖范围。

示例：9 循环系统疾病（ICD-10 代码范围为 I00-I99）

一级目录是基于同一类疾病不同治疗方式的病种归类。依据主要诊断（ICD-10 医保版）各节分类，以及主要操作（ICD-9-CM-3

医保版)的4种属性类别,对二级目录进行归类。可用于对病种进行分类管理。

示例: I20-I25 缺血性心脏病-相关手术组

二级目录是基于同一疾病诊断不同治疗方式的病种归类。依据主要诊断(ICD-10 医保版)各亚目分类,以及主要操作(ICD-9-CM-3 医保版)的4种属性类别,对三级目录(即核心病种和综合病种)进行归类。可用于比较同一诊断的疾病治疗在不同医疗机构资源消耗差异,通过对二级目录设置监管指标,以引导医疗机构以最适宜的技术、方法及成本满足患者诊疗需求,避免临床的过度治疗以及资源浪费。

示例: I25.1 动脉硬化性心脏病-相关手术组

(三) 保障医保基金平稳运行

医保维度,对比改革前后,评估实施DIP是否能够提升当地医保基金使用效率,保障医保基金安全运行。

具体监测指标可包括:

时间消耗指数、费用消耗指数、用于DIP的住院医保基金额度同比、住院总费用同比、总分值同比、点值同比、次均费用绝对值及同比、住院费用实际报销比;医保基金支出中的职工、居民住院统筹基金支出占比,职工、居民住院医保基金支出增长率,以及职工与居民次均费用差异大小等。

第三节 数据发布

一、定义

数据发布就是向各方亮医保“家底”、让医疗机构“比绩效”、定期查找医疗服务行为中的“违规”情况，即围绕“钱”、“效”、“错”，开展全面的数据分析和发布。

为了切实推进这一工作，国家医保局要求各统筹区成立医保数据工作组，主要负责医保数据的审核分析、定期公布和医疗机构的意见收集情况，常态化向定点医药机构发布医保基金运行、支付方式改革、医疗机构运行等情况，通过数据共享与治理，打破信息壁垒，优化资源配置，加强医保基金监管和风险控制，提升基金使用效率，推动“三医”协同发展和治理。

数据工作组成员由医药管理、规划财务、经办机构、数据管理等医保部门工作人员，以及定点医疗机构代表组成。

二、目的要求

（一）目的

开展数据发布，旨在加强医保部门与定点医药机构之间的信息互通和政策协同，增强医保基金运行和支付方式改革的透明度，引导医疗机构合理配置资源、规范服务行为、加强内部管理，提高医保基金使用效率和医保治理水平。

（二）要求

统筹地区医保部门负责建立医保数据工作组并组织开展数据发布工作，省级医保部门负责统筹指导。医保数据工作组由医保部门相关业务人员和定点医疗机构代表组成，可结合实际建立成员库并动态调整。

建立“月度常规推送、半年集中发布”机制。月度常规推送主要通过医保信息平台、邮件等方式，定期向定点医药机构推送数据，

原则上在上一个月结算完成后的 15 个工作日内完成，一年不少于 12 次。半年集中发布原则上一年不少于 2 次，首次集中发布应于清算完成后 1 个月内完成，主要发布上一年度全年情况；第二次原则上于 10 月底前完成，主要发布当年度上半年情况和基金监管情况。

鼓励各地结合实际创新数据发布方式，运用大数据模型、人工智能、移动终端等技术，形成个性化分析报告，向不同对象分类精准推送，提升数据服务的智能化和精细化水平。

三、主要内容

数据发布要充分考虑各方对数据需求的差异，对不同对象提供的内容应有所侧重。基本内容以《医保数据工作组数据底稿》为基础，按“月度常规推送、半年集中发布、按病种专题分析”等形式进行数据分析和发布。

（一）月度常规推送

月度常规推送的内容应包括数据底稿指标，对基金运行、支付方式改革运行、医保医疗服务利用情况和其他重点事项等进行简要分析。其中，DIP 相关重点指标应包括：医保结算清单上传率、医保结算清单质控通过率、按病种付费结算人次、按病种付费实际结算覆盖的病种数、按病种付费基金支出、按病种付费基金结余留用率、超支分担医疗机构数及基金额、特例单议申请病例数量、审核通过病例数量、特例单议病例结算金额、特例单议病例追加金额，以及特例单议病例数占出院病例数比例等。

同时，应结合门诊人次、出院人次、住院总费用、医保外费用占比、住院医疗服务性收入占比、时间消耗指数、费用消耗指数、

医保基金支出基层医疗机构占比、住院率等指标，动态掌握支付方式运行情况和医疗服务行为变化趋势。

（二）半年集中发布

半年集中发布要坚持问题导向和结果导向，各地要结合工作实际，在数据底稿的基础上，聚焦“钱”“效”“错”，丰富集中发布的内容，剖析数据提示的问题，分析原因，提出解决措施。

“钱”，主要是基金运行情况。应系统发布基金收入、支出、结余以及总额预算执行等情况，分析基金收入增幅、支出增幅及其匹配关系，研判基金安全和支付方式运行的平衡情况。

“效”，主要是改革成效和基金使用效率。应重点分析支付方式改革运行、病种付费基金支出、结余留用与超支分担、特例单议、时间消耗指数、费用消耗指数、基层医疗机构基金占比、即时结算等情况，评价改革运行成效和资源配置效率。

“错”，主要是异常情况和问题线索。应聚焦基金使用效率偏低、低标入院、重复住院、高套病组、住院率异常、医保外费用占比异常、特例单议异常集中等问题，通过数据比对和异常分析识别重点机构、重点病种和重点行为，并与协议管理、基金监管和现场核查做好衔接。

（三）按病种专题分析

按病种专题分析要以病种为重点，反映区域病种的医疗费用结构及变化趋势。半年集中发布均要将病种专题分析纳入发布范围。统筹地区应结合医保管理需要，优先选择结算人次较多、结算金额较大、趋势变化明显、入组结算问题比较突出、医疗机构关注度较高的病种开展专题分析，每次原则上至少遴选 2 个病种。

病种专题分析所需数据包括但不限于医保结算清单表、结算信息表、费用明细表和 DRG/DIP 分组结果表。对提取的数据应做好清洗和质量控制，确保数据真实、完整、准确、可比。

病种专题分析的方法和内容包括：

1.一般性分析

从统筹地区角度，按照时间段、病组类型、机构等级等不同维度，分析入组病例数、平均住院日、次均费用、自付比例等指标；从医疗机构角度，分析同级同类医疗机构之间以及与统筹地区平均水平之间的差异情况；从病种角度，重点分析病种入组病例数及占比、费用构成（药品、耗材、诊疗）等。

2.重点数据分析

以异常值为线索，对超支或结余较多的病种、收治病例数异常增减的病种、特例单议较为集中的病种，从同级同类机构、统筹地区平均值、历史同期变化等维度进行比较分析，识别可能存在的诊疗行为变化、资源配置偏差或入组结算问题。

3.使用频度分析

对单一病种下药品、耗材和医疗服务项目的使用频率开展分层分析。可结合当地实际，将项目使用频度划分为高频、中频、低频，对不同医疗机构同一病种下项目使用频度进行比较，识别诊疗行为中的集中趋势和离散差异，为发现不合理使用、过度使用或替代使用问题提供线索。

4.综合分析方法

可综合运用趋势分析、排序比较、结构分析、分层归类、逻辑验证与归因分析、交叉分析等方法，对病种费用变化、结余或超支

变化、病种结构变化、同级同类机构差异等进行综合研判，提高病种分析的针对性和解释力。

四、结果应用

医保部门加强对数据结果的分析和应用，将部分指标纳入常规监测，探索与医保定点管理、医保支付、协议管理结果等关联；督促数据发布中存在异常数据、疑点数据的医疗机构做好自查分析和问题整改。对于分析发现疑点问题需要现场核查，属于协议管理范围的，可由医保经办部门进行现场核查；涉及欺诈骗保的，可由基金监管部门进行现场核查。

同时，应将病种专题分析结果作为优化病种分组、完善支付标准、加强特例单议管理、改进数据治理和规范医疗服务行为的重要依据。对结余留用率、特例单议、时间消耗指数、费用消耗指数、住院率等核心指标异常波动的病种和医疗机构，应加强沟通反馈、跟踪监测和问题研判，推动按病种付费运行持续优化。结合年度数据发布情况，应及时总结经验，反馈医疗机构意见建议，形成数据发布、问题整改、规则优化和政策完善的闭环。

附录：

名词解释

1.按病种分值付费（Diagnosis-Intervention Packet, DIP）是利用大数据优势所建立的医保支付管理体系。基于“疾病诊断+治疗方式”的共性特征，对病案和医保结算清单数据进行客观聚类，形成病组，对各病组测定分值，再依据医保基金预算计算点值，用病种分值和点值形成支付标准，对 DIP 病组实现标准化支付并配套相应监管考核的医保支付方式。

2.病种库 国家层面统一确定 DIP 国家病种库、核心与综合病种的划分标准等。DIP 改革地区以国家病种库为基础，根据本地数据，按照统一病种组合规则，形成本地 DIP 病种库。

3.病例数临界值 指 DIP 成组过程中，结合当地病例数量测算得到单个核心病种病例数量的最小值，用于划分核心病种、综合病种。

4.核心病种 指 DIP 使用医保版疾病诊断代码前 4 位和手术操作代码聚类成组，基于疾病与治疗方式的共性特征穷举与聚类，对形成的病种组合按照病例数从高到低排列，病例数达到病例数临界值以上的病种作为核心病种，包括内科诊疗组、手术操作组。

5.综合病种 指 DIP 病种组合按照病例数从高到低排列，对病例数在临界值以下的病种，再次进行收敛，按照医保版疾病诊断代码前 3 位和治疗方式的具体属性聚类组合，包括内科诊疗组、诊断性操作组、治疗性操作组、相关手术组。

6.基层病种 是核心病种中的一个类别，指 DIP 实施过程中，地方可根据本地实际情况，在适宜基层医疗机构开展且基层具备诊治能力的病种中，选取一定数量的病种，设为基层病种。不区分医疗机构等级系数，探索同病同治同价，即采用同一分值与所有医疗机构结算。

7.病种分值 既依据真实世界的全口径（包括医保患者及自费病人）历史费用数据计算，又结合临床论证和大数据分析予以校正。从中体现疾病的严重程度、治疗的复杂程度。病种的平均医疗费用水平越高，赋予的数值越高。

8.药品分值 依据全样本数据病例平均药品费用测算，是反映不同病种组合中药品消耗程度的相对值，数值越高，反映该病种的药品消耗越高，反之则越低。

9.耗材分值 依据全样本数据病例平均耗材费用测算，是反映不同病种组合中耗材消耗程度的相对值，数值越高，反映该病种的耗材消耗越高，反之则越低。

10.医疗机构调节系数 又称医疗机构等级系数、医疗机构调整系数等，具体指 DIP 政策下，基于定点医疗机构的级别、功能定位、医疗水平、专科特色等将医疗机构分为不同等级类型，设置医疗机构调节系数，体现各级别类型医疗机构之间治疗同种疾病所需次均住院费用的比例关系。

11.辅助分型调节系数 指根据 DIP 病种内导致病例费用存在明显差异的主要影响因素，选择适宜的辅助分型应用类型，对受影响的病种进行细化分型，测算辅助分型调节系数，用于对病种分值进

行校正，从而使病种的付费标准更贴近临床实际的治疗过程与资源消耗。

12.特例单议 又称特殊病例评议，指对于住院天数明显高于平均水平、费用偏离度较大、ICU 住院天数较长或者运用新医疗技术等特殊病例，定点医疗机构可提出按特殊病例结算的申请，积累到一定例数后赋予分值。经协商谈判后医保基金可予以支付。

13.变异系数（Coefficient of Variation, CV）指 DIP 病种组合中各病例医疗费用分布的离散程度（资源消耗差异），简称 CV，其计算为标准差与平均值之比。CV 值越小，变异（偏离）程度越小。DIP 具有“一病一操作一组”及组内差异较小等特点，全样本平均组内变异系数在 0.6 左右。可通过设定 CV 值的阈值，如遴选 $CV > 0.7$ 的病种引入辅助目录细化分型。计算公式为：变异系数 =（某病种组合中各病例医疗费用的标准偏差 ÷ 某病种组合中各病例医疗费用的平均值）× 100%

14.按病种付费总额 按病种付费总额是指医保统筹地区按照以收定支、收支平衡、略有结余的原则，综合考虑各类支出风险的情况下，结合物价水平、参保人医疗消费行为、住院人次及流向、医药费用增长、医保基金增长及多元复合支付方式等因素，在年度医保基金（含职工医保和居民医保）中，单独核定用于住院按病种付费的基金总额。医保部门要建立健全医保经办机构与定点医药机构的谈判协商机制，合理确定按病种付费总额。

15.年初点值 基于前几年（通常为三年）的住院总费用，同时考虑区域服务人口、区域疾病谱以及医保总额资金可能出现的变化，

计算预算阶段的点值均值，并以优质区间测算的方法精准测算年初点值，形成预估支付标准，作为预算编制的基础、过程控制的标准以及预付预扣的参考。

16.结算点值 基于当年医保支付总额与医保支付比例核定年度住院总费用，并结合年度 DIP 总分值，计算结算阶段的点值均值，并以优质区间测算的方法精准测算结算点值，形成 DIP 支付标准，用于与定点医疗机构进行年度清算。

17.月度预付 指按照预先设立的规则，考虑医疗机构的疾病收治、违规行为以及医疗保险基金的经营情况，月初向各定点医疗机构预拨付一定的住院基本医疗保险费用月度预结算金额。

18.年度清算 指当年度结束时，根据基金收入、DIP 医保基金支出，结合协议管理、年度考核结果、监测评估等因素，形成年度综合绩效评价，落实各医疗机构医保服务质量保证金、区域调节金等，计算结余留用或合理超支补偿金额，与各定点医疗机构的数据核对，回顾年度已支付金额，确定最终清算结果，向定点医疗机构拨付医保基金。

19.病例组合指数（Case Mix Index, CMI）是指出院病人例均分值，与医院收治的病例类型有关，综合反映医院收治病例疾病复杂程度及治疗难度。CMI 值越高，代表医院收治疾病的疑难危重度越高。CMI 是一个相对值，可通过监测其动态变化和横向比较，评价医疗机构的医疗服务质量。计算公式为：病例组合指数 = $(\sum (\text{某病种的分值} \times \text{该病种的病例数})) \div \text{总病例数}$

20.时间消耗指数 指医院完成现有病种结构的服务相对于统筹

区平均水平的时间消耗情况，反映医院治疗同类疾病所需住院时间长短，均值为 1。计算公式为：时间消耗指数=〔 Σ （每个病例住院天数÷该病例所属病种的区域内平均住院天数）〕÷总病例数

21.费用消耗指数 指医院完成现有病种结构的诊疗服务相对于统筹区平均水平的费用消耗情况。反映医院治疗同类疾病所需费用的高低，均值为 1。计算公式为：费用消耗指数=〔 Σ （每个病例医疗费用÷该病例所属病种的区域内平均费用）〕÷总病例数

医疗保障按病种付费管理暂行办法

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团医疗保障局：

为全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照《中共中央 国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》要求，加快建立管用高效的医保支付机制，全面总结 2022-2024 年按病种支付方式改革三年行动计划有效做法，做好改革任务衔接，持续推进以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式改革提质增效，国家医疗保障局制定了《医疗保障按病种付费管理暂行办法》，现印发给你们，请认真落实，确保工作取得实效。

第一章 总则

第一条 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民健康为中心，深入贯彻落实《中共中央 国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》，为推进按病种付费为主的多元复合式医保支付方式改革，规范按病种付费管理，建立全国统一、上下联动、内外协同、标准规范、管用高效的医保支付机制，赋能医疗机构高质量发展，制定本办法。

第二条 本办法适用于医保部门以按病种付费方式与医疗机构结算住院医疗费用的管理。本办法提到的按病种付费包括按病组（DRG）付费和按病种分值（DIP）付费两种形式。

第三条 国家医保局统筹推进以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式改革，制定政策文件，明确改革方案和技术标准，指导

全国层面改革工作。省级医保部门对推动支付方式改革负主体责任，按照国家要求落实省域内按病种付费管理职责，指导统筹区医保部门支付方式改革工作，逐步实现省域内病种付费政策、技术标准和服务管理统一。统筹地区医保部门负责具体工作落实，加强与相关部门、医疗机构的协调配合，细化实施办法和管理措施，有序推进改革落地。

第二章 总额预算管理

第四条 医保部门按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《社会保险基金财务制度》等法律法规和政策要求，坚持以收定支、收支平衡、略有结余的原则，合理编制年度基金支出预算，支出预算调整保持在一定合理范围内，确保医保基金可持续。

第五条 统筹地区医保部门在基金支出预算的基础上，应充分考虑当地经济社会发展水平、医保基金运行情况、人民健康需求等因素，合理确定按病种付费总额。

第六条 统筹地区医保部门要严格收支预算执行。特殊情况需调整按病种付费总额的，可根据基金实际收入、就医人数变化、待遇政策调整、重大公共卫生事件等因素，按规定程序执行，要确保医保基金使用效益，维护医疗机构和参保人员合法权益。

第三章 病种分组

第七条 国家医保局负责制定和调整国家版病种分组方案根据医保管理要求和医疗服务实际需要，收集汇总医疗机构反映的意见建议，以医保结算真实数据为基础，通过临床论证和数据验证，征求

相关部门意见后，形成病种分组方案。

省级和统筹地区医保部门做好病种分组方案落地，在坚持 DRG 核心分组与国家一致，DIP 病种成组规则与国家一致的前提下，按照国家制定的技术规范，结合实际形成本地 DRG 细分组和 DIP 病种库，也可直接使用国家版分组。有条件的省份可逐步实现病种分组省内统一。

第八条 DRG 分组包括主要诊断大类、核心分组和细分组主要诊断大类根据解剖部位和疾病性质确定，核心分组主要通过临床论证进行调整，可由相关学（协）会开展行业论证，也可开展多学科联合论证。细分组是对同一个核心分组内的病例按照病情严重程度、疾病个体差异等进一步细分。

DIP 病种库包括核心病种和综合病种。通过设置病例数临界值区分核心病种与综合病种，病例数达到临界值以上的病种组合归入核心病种，作为 DIP 结算的主要付费单元。病例数临界值基于国家技术规范，结合当地实际情况确定。

第九条 国家医保局依托全国统一的医保信息平台采集医保结算清单、医疗费用明细等相关数据，按照一定质控规则对数据进行清洗、处理，形成基础数据库，作为分组基础。

第十条 各级医保部门建立常态化意见收集反馈机制，按照属地化管理原则，分级分类做好按病种付费意见收集反馈和汇总上报工作。定点医疗机构建立本单位的意见收集机制，向统筹地区医保部门定期提交医疗机构意见建议。各地可拓展意见收集渠道和方式，通过线上线下多种形式收集医疗机构、一线医务人员对支付政策、

技术规范、分组方案、信息化建设、编码标准等方面的意见建议，各级医保部门按规定做好反馈。

第十一条 国家建立病种分组方案动态调整机制，根据客观数据、意见建议、临床特征规律、政策调整变化等因素，进行定期调整。原则上每两年调整一次病种分组，并在当年7月底前发布。国家版病种分组方案调整后，省级和统筹地区医保部门要结合实际，及时调整本地分组。必要时，可适时调整。

第十二条 DRG 分组方案调整，在保持主要诊断大类相对稳定的基础上，重点调整核心分组和细分组。DIP 病种库调整，重点包括核心病种和综合病种。

第十三条 统筹地区医保部门可结合实际，研究制定适合本地基层医疗机构开展的基层病种，实现“同病同质同付”。有条件的省份可探索统一全省基层病种

第四章 核心要素

第十四条 完善 DRG/DIP 病种权重（分值，以下统称权重）、费率（点值，以下统称费率）、调整系数等核心要素管理和动态调整机制，促使病种付费标准能更加体现医疗资源消耗，提高医保基金使用效能。

第十五条 病种权重以当地历史住院费用为基础，通过该病种组合中所有病例与本地全部病例的平均住院费用的比值确定。

各地可根据资源消耗结构、疾病诊治难易程度、医保政策目标、临床学科发展等，通过专家论证、谈判协商等适当调整病种权重。权重调整时，原则上保持总权重不变，以病种为单位进行内部结构

调整。逐步探索省域内病种权重统一，引导医疗资源合理配置。

第十六条 各地可根据病种付费运行实际情况和医保基金承受能力，选择费率确定方式。

（一）固定费率法，依据历史数据测算并预测，事先确定费率，原则上在一个清算周期内保持固定不变。

（二）浮动费率法，年初按照上一年度费率等因素确定初始费率，依据当年实际运行总费用及总权重，年度清算时确定最终费率。

（三）弹性费率法，依据历史数据，结合总额预算、医疗机构收治患者的疾病严重程度、病种资源消耗及医生劳动价值等因素因地制宜实行固定费率和浮动费率相结合的方法。

第十七条 病种支付标准原则上为相应病种权重、费率的乘积。统筹地区可针对不同医疗机构特点，确定相应调整系数。

第十八条 统筹地区医保部门建立谈判协商机制，以客观费用、基金支出为基础，实际病种数据为依据，与医疗机构代表就病种付费总额、分组、权重、费率等内容进行充分沟通，协商一致。

第五章 特例单议

第十九条 医保部门建立特例单议机制，完善相关制度，规范特例单议标准、申报程序、审核流程、结算办法等，结合国家支持创新药和医疗器械发展有关政策要求，支持医疗机构收治复杂重症患者、合理使用新药耗新技术。

第二十条 申报特例单议的病例包括但不限于因住院时间长、资源消耗多、合理使用新药耗新技术、复杂危重症或多学科联合诊疗等，不适合应用病种支付标准的病例。特例单议病例数量原则上不

超过统筹地区 DRG 出院总病例的 5%或 DIP 出院总病例的 5‰。

第二十一条 医疗机构可根据申报条件，自主申报特例单议病例，特例单议数量应符合国家和地方相关规定。医保部门应畅通特例单议受理渠道，完善工作制度，优化工作流程，简化上报材料，提升评审效率，可同步开展线上、线下受理及评审，改善申报体验。鼓励医疗机构优化内部管理，减轻申报特例单议工作负担。

第二十二条 统筹地区医保经办机构负责组织特例单议病例评审，一般按月或季度开展。评审可采取智能评审和专家评审相结合的方式，也可探索线上线下评审、医疗机构交叉评审等方式进行。医保部门根据评审意见，作出特例单议评审通过或不予通过的结果判定，并及时告知申请医疗机构。有条件的地方可缩短评审周期，提高工作效率。

第二十三条 对评审通过的病例，可按项目付费或调整该病例支付标准等方式予以合理支付。对评审不通过的病例，仍按病种规定付费。

第二十四条 统筹地区医保经办机构定期向医疗机构或社会公开特例单议申报及评审情况，接受监督。公开的内容主要包括各医疗机构申报特例单议的数量、审核通过数量、占按病种出院病例比例、医保基金支付、占医保基金支出比例等情况。

第六章 结算清算

第二十五条 统筹地区医保经办机构要按照协议规定，严格做好基金预付、结算、清算等工作，及时结算和拨付医疗保障基金。对医疗机构申报的相关费用，严格按规定审核、核查，确保基金使用

规范。

第二十六条 各地应按规定做好基金预付，结合实际进一步完善预付金管理，根据统筹地区医保统筹基金累计结余和医保基金运行风险等级等因素确定是否进行预付以及预付金规模等，预付规模应在1个月左右。

第二十七条 各地要推动月度按病种实际结算，并落实基金结算改革要求，推进医保与定点医药机构即时结算，采取多种措施缩短结算周期，减轻医药机构资金周转压力。

第二十八条 各地应不断提升医保基金清算效率，加强对定点医疗机构绩效考核，充分利用考核结果，做实按病种付费清算工作。上年度清算完成后一个月左右，做好数据发布工作，提高医疗机构对医保基金清算结果的知晓度。

第二十九条 发挥医保支付引导作用，医疗机构通过规范服务行为、主动控制成本获得的病种结余资金，可作为业务性收入。同时，做好医保结余留用政策与集中带量采购等衔接，形成政策合力。

第三十条 省级医保部门按规定公开医保基金收支数据，指导省域内各统筹地区做好数据公布。统筹地区医保部门负责建立医保数据工作组，定期向医疗机构公布基金收支、按病种付费、结算清算等情况。

第七章 配套措施

第三十一条 医保经办机构要切实履行按病种付费经办管理职责，将按病种付费相关要求纳入协议管理，细化具体措施，压实协议主体履约责任。

第三十二条 做好医保支付政策宣传解读，加强对医保部门、医疗机构的按病种付费相关知识培训，将按病种付费技术培训作为年度工作纳入常态化管理，规范培训内容，创新培训形式，切实提高相关工作人员业务能力。

第三十三条 医保部门应加强对按病种付费管理运行成效的监测评估，从医保可持续、医疗增效能、群众得实惠等不同维度进行综合评价，客观全面反映改革成效，及时总结发现问题，为医保支付政策调整提供依据。国家层面完善按病种付费可视化监测，推动实现病种结算结果可比较可分析。

第三十四条 加强按病种付费智能审核和监控。根据按病种付费特点，完善智能监管规则，推进事前提醒接入和应用，重点对分解住院、高编高套、转嫁住院费用等造成医保基金损失的行为进行监管。创新监管方式，加强大数据筛查分析，推动线上智能监管与线下专项检查、飞行检查相结合，加大欺诈骗保打击力度。

第三十五条 加强支付方式改革与医保标准化工作、医疗服务价格、集中带量采购、医保目录谈判、医保待遇政策、商业健康保险等工作协同。加强按病种付费等多元复合式医保支付方式与公立医院高质量发展、基层医疗卫生服务体系能力建设、分级诊疗等医药卫生体制重点改革的协调联动。

第三十六条 医保部门指导医疗机构按协议约定上传包括医保结算清单等全量数据，确保数据全面、准确、及时，加强清单质控和数据治理，提高数据质量，为按病种付费提供可靠依据。加强重要数据和敏感字段保护，强化数据安全。

第三十七条 国家和省级医保部门应加快推进全国统一的医保信息平台支付方式管理子系统优化完善，满足统筹地区医保部门按病种付费业务需要，为医保支付管理提供数据和平台支撑地方版 DRG 细分组和 DIP 病种库要通过支付方式管理子系统上传到国家端，实现地方分组方案、入组结果、支付标准等可查询。

第八章 附则

第三十八条 医保部门要积极探索长期住院、门诊、中医优势病种等支付方式改革，形成以按病种付费为主的多元复合医保支付新格局。有序推进省内异地就医和跨省异地就医纳入按病种付费范围。

第三十九条 按病种付费适用于基本医保、大病保险和医疗救助等。异地就医住院费用按病种付费管理参照本办法执行。本办法由国家医疗保障局负责解释，自下发之日起施行。

按病种付费医疗保障经办管理规程

(2025 版)

为贯彻落实《中共中央 国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》，根据《国家医疗保障局办公室关于印发按病组和病种分值付费 2.0 版分组方案并深入推进相关工作的通知》要求，深化医保支付方式改革，提高医疗保障基金使用效率，保障参保人员权益，做好按病种付费经办管理工作，现制定本规程。

第一章 总则

第一条 按病种付费是深化医保支付方式改革的重要组成部分，目标是促进医疗卫生资源合理利用，体现医务人员劳务价值，保障参保人员待遇水平，推进医保基金平稳高效运行。本规程提到的按病种付费包括病组付费（DRG）和病种分值付费（DIP）两种形式。

第二条 医疗保障经办机构（以下简称“经办机构”）依据医疗保障行政部门制定的支付政策以及病种分组、特例单议、数据工作组、意见收集等支付机制规定，开展按病种付费经办管理，发挥结余留用、合理超支分担等激励约束作用，开展运行分析和评价考核，及时反馈医保政策执行情况，为参保人员购买高质量、有效率、能负担的医药服务。

省级经办机构要组织并指导统筹地区开展按病种付费经办管理工作，监测评估按病种付费经办运行情况，开展相关培训交流，不断提升经办管理服务能力。

第三条 本规程适用于纳入按病种付费的本地和异地住院医疗费用的经办管理工作。

第四条 完善“1+3+N”多层次医疗保障体系下的按病种付费经办管理，加强按病种付费与医疗服务价格改革、集中带量采购、医保目录谈判、商业健康保险、基金监管等工作的协同。做好与即时结算、直接结算、同步结算的协同推进。加强与公立医院高质量发展、紧密型县域医共体建设、推动检查检验互认等医改工作的协调联动。

第二章 协议管理

第五条 将按病种付费纳入协议管理范围，经办机构与定点医疗机构通过签订医疗保障服务协议，明确双方权利义务。

第六条 按病种付费相关的协议内容原则上包括：按病种付费的定点医疗机构做好信息系统完善、医疗保障基金结算清单（以下简称“结算清单”）及相关数据上传等工作；经办机构明确医保基金结算方式、拨付时限、支付标准、考核评价等管理要求。统筹地区根据按病种付费实际需要，完善协议管理内容，落实按病种付费经办管理流程，强化定点医疗机构履约责任。省内异地就医住院费用纳入按病种付费范围的，应纳入就医地协议管理。

第三章 数据采集

第七条 加快全国统一的医保信息平台落地应用，完善数据采集、质量控制、分组方案管理、分组服务、权重（分值）和费率（点值）测算、结算清算、审核核查等功能，深化支付方式管理子系统 DRG/DIP 相关功能模块应用，为按病种付费管理提供数据和平台支撑。推进智能审核、病例评审、运行监测等个性化配置，构建全流程线上管理体系。指导定点医疗机构及时做好医保信息平台数据库动态维护、编码映射、接口改造等工作。

第八条 数据采集是制定按病种付费分组方案、测算支付标准、结算清算、审核核查等工作的基础。做好国家医疗保障信息业务编码标准的应用工作，统一规范使用疾病诊断和手术操作、医疗服务项目、药品、医用耗材等信息业务编码标准。指导定点医疗机构按照《医疗保障基金结算清单填写规范》等规定填报患者诊疗、医疗收费等信息，并上传至医保信息平台。

第九条 加强数据治理，开展结算清单等相关数据的质量控制工作。按照规定对上传数据进行核验，提高数据质量。

第十条 按照国家相关法律法规，开展信息系统建设和数据管理。按照数据安全的有关管理要求，采集、传输和使用数据，保障数据总体安全可控。落实网络与信息安全相关政策和标准，强化网络安全技术防护能力，做好网络与信息安全保障。加强数据安全审批，做好分级分类管理和重要数据保护，做好数据安全风险评估。

第四章 预算管理

第十一条 按照《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规，以及《社会保险基金财务制度》等政策要求，坚持以收定支、收支平衡、略有结余的原则，会同相关部门合理编制年度基金支出预算。

第十二条 在基金支出预算的基础上，综合考虑当地经济社会发展水平、医保基金运行情况、医疗资源配置规划、人民健康需求等因素，科学编制按病种付费等预算。可根据基金运行情况、医疗卫生资源规划和发展、群众就医实际需求等，在预算中预留一定比例，统筹用于年中调整、年度清算时的合理补偿及超支分担。省级

医保部门要指导统筹地区探索将省内异地住院结算的医保基金纳入就医地预算管理。

第十三条 预算执行中，可根据基金结余、就医人数变化、相关重大政策调整、重大公共卫生事件等因素，按程序调整按病种付费预算，提高医保基金使用效率，维护医疗机构和参保人员权益。

第五章 核心要素管理

第十四条 按照国家 DRG 技术规范，在 DRG 核心分组（ADRG）全国一致的基础上，制定本地 DRG 细分组（DRGs）。各省可建立本地分组方案动态调整机制，探索全省统一分组。病组付费的支付标准主要通过权重、费率计算。

按照国家 DIP 技术规范，结合地方实际确定本地 DIP 病种目录，也可直接使用国家版分组。根据 DIP 运行情况、新技术运用、政策调整、医疗机构意见建议等，适时调整本地目录库。病种分值付费的支付标准主要通过分值、点值计算。

第十五条 权重（分值）反映不同病组（种）的医疗资源消耗相对于平均医疗资源消耗的程度。基础权重（标准分值）通常采用该病组（种）的次均医疗费用与统筹地区次均住院医疗费用的比值表示，也可采用基准病种费用法或标准定额法计算。权重（分值）越高，代表该病种消耗的医疗资源越多。总权重（分值）为各病组权重（病种分值）与患者例数乘积之和。可在总权重（分值）不变的原则下，根据地方实践经验和历史数据、协商谈判结果、优化医疗资源消耗结构等因素，对不同病组（种）基础权重（标准分值）进行调整优化，形成付费权重（分值）。权重（分值）调整应统筹

考虑本地和异地住院医疗费用情况。

第十六条 费率（点值）反映在按病种付费等预算基础上，每一权重（分值）的医疗费用值。可结合实际需要选择费率（点值）确定方式，包括固定费率、浮动费率、弹性费率（点值包括预算点值、结算点值）等。

第十七条 根据定点医疗机构级别、功能定位、医疗水平、专科特色、病组结构等因素，合理设置系数，促进因病施治，推进分级诊疗。

第十八条 病组付费的支付标准通过费率乘以权重、系数计算。病种分值付费的支付标准通过分值乘以点值、系数计算。根据医保基金实际运行情况，适时对权重（分值）、费率（点值）、系数进行动态调整。

第十九条 对占基层医疗机构病例比重较大，医疗费用相对稳定，变异系数较低且适宜基层医疗机构开展的常见病、多发病、慢性病等，可设置基层病种，不区分医疗机构级别、系数，在统筹地区实行同病同支付。

第六章 特例单议

第二十条 申报特例单议的病例原则上应为住院时间长、医疗费用高、新药耗新技术使用、复杂危重症或多学科联合诊疗等不适合按病种付费的病例。

第二十一条 各统筹地区依据特例单议申报标准、申报程序、审核流程、结算办法等规范，开展审核评议。DRG 特例单议数量原则上不超过统筹地区 DRG 出院总病例的 5%，DIP 特例单议数量原

则上不超过统筹地区 DIP 出院总病例的 5%。

第二十二条 特例单议可由医疗机构自主申报，采取线上或线下的方式，按季度或按月等方式开展，通过智能评审与专家评审相结合等方式对特例单议病例进行审核评议。

第二十三条 对评审通过的病例，可实行项目付费或调整该病例支付标准。对评审不通过的病例，按病种付费规定执行。

第二十四条 对医疗机构申请特例单议的数量、审核通过的数量、特例单议病例数量占出院病例数比例等按时进行公告并形成机制，特例单议结果纳入当年按病种付费清算。

第七章 结算清算

第二十五条 按照规定建立医保基金预付制度。满足基金预付条件的地区，要合理确定预付金基础规模，结合定点医疗机构年度考核、信用评价等情况进行调整，预付规模应在 1 个月左右。规范预付金管理流程，做好对账核算工作，会同财政部门强化监督。

第二十六条 积极推进医保与定点医疗机构即时结算，与以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式做好衔接。可预留一定比例（不超过 5%）作为质量保证金，结合考核评价情况在年度清算进行拨付。

第二十七条 根据医保基金预算、核心要素核定结果、特例单议等支付机制运行结果、结余留用合理超支分担等方面，结合协议考核、考核评价、监测评估等结果，开展年度清算。按照规定时限向定点医疗机构拨付清算资金，并指导定点医疗机构对医保清算资金拨付情况进行确认，督促定点医疗机构按照财务会计制度等规定

对应由其承担的医疗费用及时进行账务处理。通过落实数据公开、意见收集、特例单议、协商谈判等机制，减少年度清算压力，缩短清算周期。

第八章 审核核查

第二十八条 推进智能审核全覆盖，常态化开展医保数据筛查分析，完善随机抽查检查机制，提高日常审核核查能力，强化基金安全防控。

第二十九条 对定点医疗机构申报的医疗费用进行审核，推进按病种付费智能审核。对智能审核发现的疑似违规费用进行核实，对初审通过的医疗费用进行随机抽查复审，对高套病种、分解住院、低标入院、推诿病人、转嫁住院费用等疑点问题开展核查。

第三十条 对审核核查工作中发现的疑点问题，经办机构及时向定点医疗机构反馈，畅通申诉渠道，按规定对违规费用予以拒付或追回。应当由医保行政部门处理的问题线索，应及时移交。

第三十一条 畅通投诉举报途径，支持并鼓励社会各界参与监督，实现多方良性互动。

第九章 结余留用

第三十二条 建立健全“结余留用、合理超支分担”的激励约束机制，提高医疗机构自我管理的积极性。

第三十三条 结合地方实际科学合理确定结余留用的具体办法。可以从按病种付费预算、按病种应支付金额、按项目付费记账金额、单个病例医疗费用与病组病种支付标准等方面，确定结余和超支的比例、分担比例、合理区间值等。做好实施前的数据模拟测算。引

导定点医疗机构通过合理提供医疗服务获得结余，对其合理超支部分进行共担。

第十章 考核评价

第三十四条 开展按病种付费考核评价，保障按病种付费可持续运行，保证参保人员受益水平，引导定点医疗机构合理提供医疗服务。可以单独评价，也可纳入综合评价。

第三十五条 按病种付费考核评价要明确考核方式、评分主体、评分标准，建立考核指标，提高指标评价的客观性和可操作性。结合地方实际，将定点医疗机构履行医保协议、结算清单和医疗费用明细数据上传、医疗费用金额和人次变化、药品耗材集采、医疗服务质量评价、基金监管等医保政策执行情况纳入考核。加强考核结果应用，考核结果可与结余留用合理超支分担比例、基金预付、质量保证金拨付等年度清算内容挂钩。

第十一章 争议处理

第三十六条 争议处理遵循公平公正、客观合理、多方参与、及时处理的原则。开展按病种付费争议处理，及时妥善解决工作开展、履行协议过程中产生的争议问题。

第三十七条 对在按病种付费中出现的各类纠纷，可采取专家评议或其他形式，按照医疗保障服务协议及相关法律法规处理。

第十二章 数据应用

第三十八条 各统筹地区要建立数据工作组，工作组成员由医药管理、规划财务、经办机构、数据管理等医保部门工作人员，以及定点医疗机构代表组成。数据工作组主要负责医保数据的审核分

析、定期公开和医疗机构的意见收集。

第三十九条 强化与医疗机构的沟通协商，充分发挥数据工作组的作用，定期分析医保基金收支情况、预算执行情况、DRG/DIP付费、结算清算进度等，组织数据公开沟通会，按月向医疗机构公布数据，暂时不具备条件的可按季度公布。应用医保信息平台支付方式管理子系统 DRG/DIP 相关功能模块，结合地方实际开展按病种付费分析和评价。

第十三章 谈判协商

第四十条 各统筹地区要建立关于预算、权重、分值、调节系数等支付核心要素的谈判协商机制。协商谈判代表可由定点医疗机构代表、行业（学）协会、卫生健康和医保等部门共同参与，也可探索邀请参保人代表参与谈判协商。

第四十一条 各统筹地区要建立支付方式改革专家组，为支付方式改革提供技术支撑，指导定点医疗机构更好落实医保政策，也可承担特例单议、谈判协商、争议处理等工作。选择专家应坚持公开、公平、公正、择优的原则，专家评议采取回避制度。可探索专家库信息共享机制。

第十四章 意见收集

第四十二条 各统筹地区建立面向定点医疗机构、医务人员、医保医疗相关领域专家的意见收集和反馈机制，为优化政策、完善分组、规范管理等提供依据和支撑。加强与卫生健康、中医药管理等部门的沟通协作。同时，定期通报交流对各定点医疗机构按病种付费实施过程中的典型案例。

第四十三条 做好按病种付费管理的宣传工作，积极回应群众关切，合理引导社会预期。充分调动各方参与、支持配合按病种付费管理工作，凝聚社会共识，提前做好风险评估，努力营造良好氛围。

第十五章 附则

第四十四条 本规程由国家医疗保障局负责解释。本规程自印发之日起实施。

第四十五条 《按疾病诊断相关分组（DRG）付费医疗保障经办管理规程（试行）》（医保办发〔2021〕23号）和《按病种分值付费（DIP）医疗保障经办管理规程（试行）》（医保办发〔2021〕27号）同时废止。

医保基金清算提质增效三年行动计划

为贯彻党中央、国务院关于深化医疗保障制度改革的决策部署，按照《中共中央 国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》，进一步优化医保基金结算管理，加快构建与“1+3+N”多层次医疗保障体系相适应的科学结算体系，在推进医保基金清算工作取得初步成效的基础上，利用三年时间达到清算提质增效的目标，制定本行动计划。

一、工作目标

在高质量完成医保基金结算的基础上，推进清算提速，自 2028 年起，实现每年 3 月底前完成上年度清算，清算资金占年度医保基金拨付的 3% 左右，推进季度清算等创新模式。鼓励有条件的地方，探索将大病保险资金和医疗救助基金等纳入清算提速范围，逐步缩短异地就医费用清算周期。

二、建立工作机制

医保基金清算改革是一项系统工程，各地要秉持改革创新、自我革命的思想，破除年度清算的难点堵点，重在建立完善长效机制，强化日常工作，夯实清算基础，把“解决问题”的功夫下在平时，多措并举加快推进清算提质增效。

（一）统筹协调机制。

清算涉及面广，政策性强，各地医保部门要凝心聚力、形成改革合力，强化内部协同，明确职责分工，促进部门协作，形成改革合力。预算管理、综合考核、支付方式、药耗集采、经办管理、信

息数据等部门，要按照职责分工，完成清算相关任务。方案制定、综合考核等综合性工作，要明确牵头部门和配合部门职责。总额预算管理方面，要强化总额预算编制和执行，做好门诊和住院、本地和异地、相关支付方式的预算分配，将清算资金额度配置在规定区间。医保部门要做好预算绩效考核。支付方式方面，明确各种支付方式政策和标准，尤其是按病种付费的分组、核心要素（如权重、分值、费率、点值）、支付标准等要求，为清算提供政策依据。结算清算方面，要做好预算执行，推动医保政策在结算清算阶段的落实反馈，应用管理工具、系统功能、数据信息等做好清算资金拨付和账务处理。药耗集采方面，及时将药耗采购规格、剂型、报量、金额、周期、集采标识等信息发送给结算部门，提供药耗资金拨付依据。信息系统方面，要加快结算清算相关系统功能完善，深化医保信息编码标准应用，持续加强结算清算数据治理，提升清算信息化支撑。

（二）流程规范机制。

省级医保部门要规范全省医保基金清算流程，指导统筹地区规范有序推进清算工作。要运用系统思维，统筹安排清算环节、任务、资源、时间，按照“最小必须”原则精简优化流程，推进清算标准化、科学化、规范化。

（三）系统支撑机制。

要持续深化本地医保信息平台清算功能模块应用，加快实现清算医保信息平台线上操作；持续推进数据治理，深化医保信息编码标准应用，不断夯实清算数据基础。进一步完善省级平台支付方式

管理子系统功能，加强子系统间的数据贯通、业务衔接，促进结算、清算连贯操作。推进省级医保业财一体化系统建设和应用，促进医保业务与财务、医保与银行流程畅通，及时掌握清算进度、资金拨付情况。

（四）信息公开机制。

医保基金清算方案，尤其是清算流程、规则、时限等内容，要征求定点医药机构意见。坚持公平公开原则，参照数据工作组定向发布规定，向定点医药机构按规定公布清算方案、清算进度、清算结果等内容，畅通监督渠道，接受社会监督，打造“阳光清算”。

三、分阶段任务

（一）起步阶段。

所有统筹地区于 2026 年 5 月底前完成 2025 年度清算，其中试点统筹地区于 2026 年 3 月底前完成。清算资金占基金拨付的比例调整到 5% 左右。省级医保部门要制定全省医保基金清算提质增效三年行动方案，明确时间表、路线图，对试点统筹地区加强指导，应用医保信息平台加快清算，推进完成改革任务。各地要推进部门协同，强化预算管理，优化清算流程，完善系统功能。争取卫生健康等部门支持，指导定点医药机构对接信息、财务等工作，提高拨付效率。

国家医保局将指导地方制定完善方案，组织经验交流，并针对反映的突出问题，及时研究推动解决。

（二）提速阶段。

所有统筹地区于 2027 年 4 月底前完成 2026 年度清算。同时，进一步扩大试点范围，试点统筹地区于 2027 年 3 月底前完成清算。

清算资金占基金拨付的比例调整到 3%-5%。依托医保信息平台完成清算。省级医保部门要总结试点经验，巩固清算成果，规范全省清算流程，指导改革全面推进。

国家医保局将组织各地开展评估，跟进地方清算改革进展情况，指导完善清算流程，总结推广经验做法。

（三）全面实施阶段。

所有统筹地区于 2028 年 3 月底前完成 2027 年度清算，清算资金占基金拨付的比例控制在 3%左右。

国家医保局将持续做好工作指导和调度，及时解决地方反映的问题，全面优化提升清算改革成效。

四、抓好主要环节

清算工作要重点抓好方案制定、数据准备、综合考核、金额核算、审定拨付等主要环节。原则上年度清算要涵盖上述环节；按季度清算等一年多次清算的统筹地区，在确保全年清算各环节实施的基础上，可简化部分清算流程。

（一）方案制定。

主要包括总额预算、清算规则、清算流程、任务分工、完成时限等。清算前要对预算总额进行核定或按程序调整，确定可用于清算的资金额度。清算方案要充分论证、听取定点医药机构意见，确定后不得随意调整。清算方案原则上要向定点医药机构公开。

（二）数据准备。

数据是清算的基础，省级医保部门要指导统筹地区把清算数据治理、审核、分析等工作分解到平时，提前做好清算数据准备，完

成好数据上传、对账申报、数据固化等。特例单议、审核、考核、对账是影响清算数据收集进度的主要因素。各地要解放思想，突破瓶颈，借助信息化，推进“马上办”“自动办”“掌上办”，化整为零，减少问题积压，化解年度集中处理业务的压力。

（三）综合考核。

综合考核主要是对定点医药机构执行医保政策、履行医保服务协议、使用医保基金绩效等方面的考核，考核结果与清算拨付金额挂钩。综合考核涉及多政策落地、多部门参与，点多线长面广，要建立完善综合考核指标体系，体现支付方式改革落实、支付配套机制实施、药品耗材集采执行等情况的部分指标合理分配到平时，注重日常考核与年度考核相结合，定量考核与定性考核相结合，线上考核与线下考核相结合，运用多种方式，提高考核的质量和效率，降低集中清算压力。

（四）金额核算。

清算金额核算要综合考虑基金运行、预算分配、点值和费率浮动等情况，结合医疗资源、医药费用等因素，将清算对医药机构的影响均衡到全年，合理引导支付预期，稳步调节基金平衡。明确门诊与住院、本地与异地、多种支付方式等的清算额度分配；明确多种支付方式的清算规则，做好按病种付费、紧密型医共体付费等清算。发挥清算资金的杠杆作用，体现“结余留用、合理超支分担”的激励约束机制，体现医务人员劳动价值，为人民群众提供优质高效的医药服务。

（五）审定拨付。

主要包括清算结果产生、确认、审定、请款、拨付。清算结束后，要反馈定点医药机构，做好沟通解读，充分听取意见建议，努力达成共识。清算结果按照程序进行审定，减少冗余环节，加快清算审核拨付程序。提前与财政部门沟通，做好资金请款准备，促进资金及时拨付。

五、加强组织保障

（一）加强组织领导，促进地方帮扶。

省级医保部门是清算工作的主体，要指导统筹地区开展清算提质增效改革，实现省内清算流程规范统一，明确关键节点、具体步骤和实施路径。重点对清算进度滞后的统筹地区，加强指导，强化培训，持续调度，组织地方“一帮一，一对红”，发挥典型示范作用，加大帮扶力度，加快提升清算能力。

（二）强化日常工作，化解清算压力。

按病种付费清算是清算的重点和难点。省级医保部门要指导统筹地区，将按病种付费相关工作分解到平时，注重日常的沟通协商和争议处理，及时解决问题，减少矛盾积压。用好特例单议、意见收集反馈、谈判协商、数据工作组等工作机制，不断完善审核反馈渠道，重视和提升医疗机构、医务人员在清算中的参与度，促进医保和医疗数据共享共通，提高医药机构对清算工作认可，促进清算时效不断提高。同时，要严格履行定点服务协议，及时足额向定点医药机构拨付协议约定的医保资金，不得拖欠医药费用。

（三）鼓励试点先行，发挥示范作用。

充分发挥试点的典型示范、辐射带动作用，清算进度要快于全

国平均进度。各省做好组织推荐，原则上试点统筹地区2个左右，至少1个开展季度清算，支持有条件的省份，全省试点。鼓励直辖市要全面推进试点，提前完成清算任务。国家医保局将加强对试点的指导和支持，及时总结经验，形成和推广可复制做法，推进目标任务的全​​面实现。

（四）加强沟通协调，注重宣传培训。

要加强沟通协调，争取财政、卫生健康等部门支持，充分听取定点医药机构意见和建议，在清算中激励管理好、效率高、政策执行到位的定点医药机构分享更多医保红利，共同提高医保基金使用质量和效率，赋能医药卫生事业发展。要加强清算提质增效改革的宣传、培训，指导统筹地区切实向定点医药机构做好政策解读，争取更多的理解和支持。及时总结地方清算的典型经验，不断扩大宣传和示范效应，推动形成三医联动的良好改革氛围。